ASSOCIATION MARIALE D'ABILI

# PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE DES HANDICAPÉS SPIRITUELS

(MTHS)

Sagesse Africaine

**Association Mariale d'Abili**

# PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE DES HANDICAPÉS SPIRITUELS (MTHS)

Tous les droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
Réservés pour tous les pays.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm, or other means without permission from the publisher.
By **Sagesse Africaine**,
Tél: (237) 677 31 44 12 / Tél: (237) 693 21 54 31
E-mail : marieconstantin51@yahoo.com
(Cameroun 2025).

*« Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de puissance,* ***lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable****, car Dieu était avec lui. »*

**(Actes 10,38)**

Sagesse Africaine

***« Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance… renvoyer libres les opprimés. »*** (Luc 4,18)

## Traditional Medicine for the Spiritually Handicapped

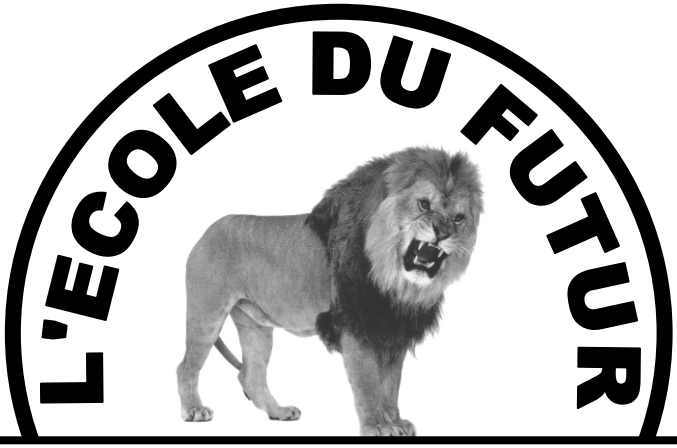
## (TMSH)

# MTHS

## Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)

**« La médecine révélée pour la guérison intégrale de l'homme : Corps, Âme et Esprit »**

***« Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramène de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu » (AC.26, 18)***




**CENTRE D'ETUDES DES TRADITIONS, US ET COUTUMES AFRICAINES ET DE LA RECHERCHE APPLIQUEE SUR L'INCULTURATION DU CHRISTIANISME CHEZ LES PEUPLES D'AFRIQUE NOIRE**

**POUR**

**- La Culture de la Paix**

**- L'Education citoyenne des jeunes**

**-- Le Dialogue des Cultures et des Religions**

**- La Valorisation des identités culturelles africaines**

**- La Vulgarisation de la Recherche sur le Développement Durable**

**- La lutte contre la déviance spirituelle et les comportements de déviance**

**Collection:**

**LUMIÈRE ET VÉRITÉ SUR LE MONDE DES TÉNÈBRES**

***Pour la promotion de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)***

1 – À la rencontre de JEAN PAUL SYLVAIN SIDA ABENA : le médecin des handicapes spirituels (Tome-1)

2- Les Dix Commandements de Satan; (Tome-2)

3- Comment reconnaître à vue d'œil un sorcier (handicapé spirituel); (Tome-3)

4- La transmission de la Sorcellerie au sein de la famille; (Tome-4)

5- Ange ou Démon ? *La nature spirituelle profonde de l'Homme;* (Tome-5)

6- La Vie nocturne du Sorcier (L'Univers astral de la sorcellerie)*;* (Tome-6)

7- Le Chrétien africain face à la Maladie (Approche clinique de la MTHS) *;* (Tome-7)

8- Le Chrétien africain face à la Sorcellerie (Approche clinique de la MTHS)*;* (Tome-7)

9- Les 05 Dimensions de conscience spirituelle de l'Homme ; (Tome-9)

10- Comment te soigner des persécutions spirituelles et des sorts de sorcellerie; (Tome-10)

11- Le Musulman face à la sorcellerie (Approche clinique de la MTHS) (Tome-11)

12- Le Bouddhiste face à la sorcellerie (Approche clinique de la MTHS) (Tome-12)

12- L'Indouiste face à la sorcellerie (Approche clinique de la MTHS) (Tome-13)

14- La Religion traditionnelle chinoise face à la sorcellerie (Approche clinique de la MTHS) (Tome-14)

15- Culture de la paix et lutte contre la déviance spirituelle dans le monde (Tome-15)

16- Comment vivre-ensemble avec des sorciers et des Satanistes : le libre arbitre et la Maitrise de soi (Tome-16 )

17- La Vie après la mort. (Tome-17)

18- La guerre des spiritualités en Afrique (Tome 18)

19- Le Remède Traditionnel Amélioré post-Covid 19

20- Protocole Thérapeutique de la MTHS (Tome 20)

# SOMMAIRE

Préface……P.07
Avant-propos……P.10
Introduction……P.22

# PRÉFACE

## 1. JUSTIFICATION DE L'OUVRAGE

### Contexte mondial et africain des souffrances spirituelles non prises en charge

Lorsque l'on traverse un pays africain, que l'on parcourt les villes, les villages, les quartiers, un même constat s'impose à l'observateur attentif : la souffrance est souvent visible, mais son origine demeure invisible.

On voit les familles brisées, les jeunes désorientés, les adultes épuisés, les communautés en proie à des conflits incompréhensibles. On entend parler de malédictions, de sorcellerie, de persécutions mystiques, de visions oppressantes, de nuits sans sommeil, d'échecs dignes d'être qualifiés de malchance structurelle. Dans beaucoup de ces situations, les victimes ont consulté médecins, psychologues, pasteurs, guérisseurs, mais l'intensité de la souffrance ne diminue pas, ou revient sous d'autres formes, plus difficiles à identifier.

Ce constat, nullement spectaculaire, est mondial : partout, des dimensions spirituelles mal comprises rendent inefficaces des approches qui ne peuvent qu'effleurer la surface d'un problème plus profond. Mais il est particulièrement aigu en Afrique, continent où la dimension invisible est historiquement et culturellement intégrée à la vie. Là où les communautés, les lignées et les territoires forment

des systèmes de sens très riches, les troubles spirituels non maîtrisés se transmettent et se glissent dans la vie concrète.

Des personnes se retrouvent dans des impasses, non simplement à cause de pauvreté ou de maladie physique, mais parce que l'âme et l'esprit de la personne, de la famille, voire de la communauté, ne parviennent plus à habiter le monde invisible de façon saine. L'absence d'outils thérapeutiques clairement définis, adaptés à cette réalité, crée un vide dans lequel la peur, la dépendance, l'exploitation mystique et la confusion doctrinale prolifèrent.

## Limites des approches biomédicales classiques face aux pathologies spirituelles

Les sciences médicales et psychologiques modernes, aussi indispensables soient-elles, sont souvent impuissantes devant certaines réalités : des rêves qui écrasent le cœur, des peurs qui échappent à toute explication rationnelle, des blocages récurrents prêts à submerger la personne à la moindre crise. On ne présente pas ces souffrances comme volonté d'écarter la médecine moderne, mais comme reconnaissance honnête de la multiplicité des dimensions humaines.

Les troubles spirituels, lorsqu'ils ne sont ni identifiés ni traités à leur niveau propre, se présentent sous les habits de l'anxiété, de la dépression, des troubles obsessionnels, des somatisations. L'approche biomédicale peut apporter un soulagement partiel, une

meilleure compréhension neurologique, mais elle ne touche pas à l'origine de ce qui se passe dans la relation de la personne à l'invisible. Sans prendre en compte cette dimension, l'accompagnement reste incomplet et la guérison fragilisée.

C'est dans ce hiatus (entre la souffrance spirituelle profonde et le manque d'outil réellement adapté) que naît l'urgence de proposer un cadre structuré, conscient des limites de chaque domaine, mais capable d'embrasser le tout humain, pour soigner au bon endroit et de façon responsable.

## Nécessité d'un protocole structuré, codifié et transmissible

Face à cette urgence, le recours à des pratiques improvisées, à des rituels confus, à des discours culpabilisants ou dominants n'offre ni sécurité ni stabilité. Sans un protocole clair, la personne en souffrance est exposée à des dérives : charlatanisme, manipulation, incompréhension des mécanismes spirituels, accidents psychiques ou sociaux.

Un protocole doit être :

- **structuré** : pour guider le parcours diagnostique, thérapeutique, de libération et de réintégration ;
- **codifié** : pour que les étapes, les critères, les responsabilités soient connus, vérifiables et évaluables ;
- **transmissible** : pour que le savoir ne dépende pas d'un individu isolé, mais puisse être partagé, adapté, enseigné, supervisé, amélioré.

L'absence de ce cadre contribue à la dispersion des efforts et à la multiplication des patients traités sans recul ni éthique. C'est pourquoi ce livre, en proposant un **Protocole Thérapeutique** de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, répond à une double exigence : témoigner de réalités observées et offrir une voie sécurisée et rigoureuse pour ceux qui veulent accompagner la guérison dans ce champ particulier.

## 2. RECONNAISSANCE DE LA MTHS COMME DISCIPLINE THERAPEUTIQUE

### Originalité de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) se distingue par son **diagnostic cliniquement ancré** et son **accompagnement thérapeutique holistique**. Elle ne réduit pas les troubles spirituels à des phénomènes occultes attribuables à un seul système de croyances, ni ne les assimile à des pathologies psychiatriques strictes. Elle les pose comme des **handicaps spirituels**, c'est-à-dire des limitations durables affectant la capacité d'un individu ou d'un groupe à habiter librement son espace spirituel, en cohérence avec son histoire, sa culture et sa foi.

Ce positionnement est original. Il relève d'une pratique née du terrain, nourrie par l'observation prolongée des conséquences de la guerre des spiritualités, de la double appartenance, du syncrétisme pathologique, de la dépendance mystique, des pactes,

des peurs légitimes mais paralysantes. Elle n'est ni pure tradition non critiquée, ni importation théorique froide : elle se situe dans une **zone de rencontre vivante** entre le savoir ancestral, la théologie chrétienne inculturée et la rigueur clinique.

## Ancrage africain, chrétien et clinique

L'ancrage africain de la MTHS est central. Il reconnaît que la culture, la mémoire rituelle, les récits familiaux, les structures communautaires ont un rôle thérapeutique potentiel, mais aussi un rôle potentiellement pathogène lorsqu'ils sont mal compris ou instrumentalisés. L'anthropologie médicale africaine apporte ici une lecture très fine du lien entre les individus, les lignées, les territoires et l'invisible. C'est un savoir qui a longtemps été marginalisé, mais qui, une fois repensé et purifié, devient source de pertinence clinique.

L'ancrage chrétien, quant à lui, donne à la MTHS une **boussole éthique** et une **dimension libératrice**. Le Christ, tel qu'annoncé dans la Bible, vient libérer les captifs, guérir les oppressés. Le texte biblique rappelle que Jésus-Christ a été oint par Dieu pour faire le bien et guérir ceux qui étaient sous l'empire du diable. Un verset précis le souligne : **Actes 10,38** affirme que Jésus allait faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ce fondement théologique n'est pas un slogan, mais une **orientation pratique** : la délivrance et la guérison spirituelle sont au cœur de la mission, dans un cadre qui respecte la dignité humaine et la liberté personnelle.

La dimension clinique de la MTHS garantit que ce savoir ne reste pas abstrait. Chaque étape du diagnostic est pensé pour observer, recueillir, analyser, confronter, puis agir. L'accompagnement est gradué, sécurisé, évalué. C'est ce mélange d'**Africanité**, de **foi chrétienne** et de **rigueur clinique** qui fait de la MTHS une discipline thérapeutique à part entière, responsive aux défis contemporains.

## Contribution à la santé intégrale (corps – âme – esprit)

La MTHS se situe dans la continuité d'une approche intégrale de la santé : le corps n'est pas dissocié de l'âme, ni l'esprit de la communauté. Quand l'individu est malade spirituellement, toute la structure vitale est déséquilibrée : relations, travail, sommeil, santé physique, projets de vie. De même, une guérison spirituelle réelle rejaillit sur le corps éclaire la psyché, stabilise les relations.

En choisissant de défendre la MTHS comme discipline thérapeutique, ce protocole ne se contente pas de proposer un outil pour quelques cas spécifiques. Il propose un **mode de soin global** où l'on prend en compte les effets d'une guérison profonde sur l'ensemble de l'existence, en vue de restaurer la plénitude de la personne. Cela rejoint la vision biblique et savante d'un humain créé pour vivre en harmonie sur tous les plans, et non pour être réduit à une seule dimension.

## 3. VALEUR SCIENTIFIQUE, SOCIALE ET SPIRITUELLE DU PROTOCOLE

### Apport à la lutte contre la sorcellerie, les persécutions mystiques et les maladies spirituelles

La sorcellerie et les persécutions mystiques sont souvent perçues comme le ressort d'un mal culturel ou de la peur irrationnelle. Cette perception ne permet ni de les comprendre ni de les traiter. La MTHS, par son diagnostic précis, permet d'identifier la nature exacte du lien avec ces réalités : est-ce une illusion nourrie par la peur ? un pacte non renoncé ? un conflit intergénérationnel encore actif ? Une dépendance ou une confusion doctrinale ? Cette compréhension permet d'agir de façon ciblée, évitant la stigmatisation, la chasse aux sorcières ou l'abandon de la tradition.

En offrant des protocoles, des grilles, des outils de discernement, le livre donne aux praticiens une **méthode** pour distinguer l'accessoire de l'essentiel. Cela autorise des interventions plus efficaces et plus sûres, capables de réduire les persécutions injustes, de restaurer l'équilibre spirituel et de diminuer le champ d'action des forces destructrices ou manipulatrices, réelles ou imaginaires.

### Impact sur la paix intérieure, familiale et communautaire

Guérir un handicap spirituel chez un individu n'est pas un acte isolé. L'impact se répercute sur la famille, pour laquelle le membre souffrant pouvait être la pierre d'achoppement ou le

médiateur de tensions plus vastes. L'impact touche la communauté, qui voit l'individu réintégré, moins instable, moins alerte à l'obsessionnel ou à la peur, et donc plus apte à contribuer.

Un protocole rigoureux encourage des pratiques qui préservent la paix intérieure de la personne, en évitant la peur, la culpabilité infinie, l'excès de rites, la dépendance à des intermediaries mystiques. Le poids de ces formes de violences spirituelles, lorsqu'elles sont réduites, libère du temps, de l'énergie, des ressources pour se consacrer à la vie, à la famille, au travail, à la communauté. Un monde spirituellement adouci est un monde socialement plus stable et plus vivable.

## Dimension éthique et humaine du soin spirituel

Un soin spirituel mal encadré peut devenir un instrument de domination. Le protocole valorise l'humanité du patient, sa dignité, sa liberté. Il prescrit non la puissance d'un thérapeute, mais la **compétence d'un accompagnateur** qui veille, non pas à accumuler des exploits, mais à voir le patient se relever.

Cette dimension éthique est essentielle pour que la MTHS ne soit pas instrumentalisée, ni récupérée pour des jeux de pouvoir, ni pervertie en commerce de la peur. Il faut rappeler que la capacité de guérir s'accompagne de responsabilités, notamment le respect de la liberté de conscience, la prévention des abus, la transparence des méthodes. La discipline est ainsi offerte comme une **science**

**humaine** aussi exigeante que les autres, avec ses propres normes, son propre savoir et sa propre éthique.

## 4. MESSAGE DE LEGITIMATION ET D'ENCOURAGEMENT

### Crédibilité du travail de terrain

L'expérience concrète, souvent négligée dans les constructions théoriques, a été la base de la MTHS. Nul ne vient ici proposer un savoir sorti d'une bibliothèque sans avoir confronté le réel, le labyrinthe des peurs, la multiplicité des récits, la complexité des lignées. La crédibilité de ce protocole est établie par des années d'observation, de cas étudiés, d'accompagnements réalisés, de rechutes analysées, de réajustements.

Ce fondement terrain rassure le lecteur (thérapeute, leader spirituel, décideur ou simple lecteur curieux) : les propositions ne sont pas hypothétiques, mais éprouvées. On entre dans une discipline vivante, pas dans un simulacre ou une doctrine abstraite.

### Appel à la lecture sérieuse et responsable

Le propos lancé par l'ouvrage dépasse la simple curiosité. Chacun est appelé à une lecture sérieuse, loin de toute surexcitation, de toute recherche de sensation. La MTHS est un **terrain de vérité et de vie**, pas un divertissement. Elle demande la disposition intérieure à changer, non seulement à comprendre. Toute personne qui s'y engage est donc invitée à un examen de

conscience, à une humilité permanente, à une volonté de vérifier et d'adapter.

Le but n'est pas de créer des disciples énervés, mais de former des accompagnateurs tranchants, prudents, intelligents, bienveillants, capables de tenir face aux enjeux multiples.

**Bénédiction et souhait de diffusion de l'ouvrage**

Nous souhaitons, du fond du cœur, que cette publication soit bénie dans sa circulation. Qu'elle trouve son chemin vers des mains ouvertes, vers des esprits désireux de vérité, vers des cœurs prêts à soulager leurs semblables.

Qu'elle soit un outil qui éclaire les zones d'ombre, ravive l'espérance, soigne sans écraser, donne du courage pour affronter les défis invisibles, et surtout, qu'elle contribue à la formation d'une communauté de praticiens éthiques, fiables, formés.

Nous bénissons ceux qui vont en prendre connaissance, les encourageons à l'intégrer, à en discuter, à l'améliorer, à la transmettre. Nous espérons qu'un nombre croissant de personnes trouveront dans ce protocole non seulement une méthode, mais un chemin, un acte de foi en la capacité de l'Afrique à se relever, à guérir et à offrir au monde une spiritualité réconciliée, responsable, et véritablement au service de la vie.

Ainsi se conclut cette Préface. Elle ne se veut pas une simple introduction technique. Elle est une tentative de poser le cadre, d'ouvrir la porte d'un engagement sérieux, et de rappeler que le chemin de la guérison spirituelle, loin d'être mystérieux, est à la portée de ceux qui acceptent d'écouter le terrain, d'apprendre, de discerner et d'aimer.

# AVANT-PROPOS

## 1. GENESE DU LIVRE

### Origine du concept de « handicap spirituel »

Ce livre n'est pas né dans le silence des bibliothèques ni dans le confort d'une spéculation intellectuelle détachée du réel. Il est né sur le terrain, au cœur des douleurs humaines, là où les mots manquent et où les explications ordinaires échouent. Le concept de **« handicap spirituel »** s'est imposé progressivement, comme une évidence clinique, au fil des accompagnements, des prières, des écoutes nocturnes, des larmes retenues et des récits fragmentés.

Nous avons constaté que certaines personnes ne souffraient pas seulement d'un mal-être psychologique, ni uniquement d'une pathologie sociale ou économique, mais d'une **atteinte profonde de leur capacité spirituelle à vivre librement**, à discerner, à choisir, à se projeter. Ces personnes semblaient entravées dans leur rapport à l'invisible, comme si une partie essentielle de leur être avait été blessée, capturée, fragmentée ou figée.

Le terme « handicap spirituel » s'est alors révélé plus juste que ceux de possession, de folie, de malchance ou même de simple oppression. Il désigne une **limitation durable**, parfois héritée, parfois acquise, qui affecte la relation de la personne à Dieu, à elle-même, à sa lignée, à sa communauté et au monde invisible. Ce handicap n'est pas une condamnation, mais un état

clinique appelant un soin adapté, progressif, respectueux et structuré.

## Expériences cliniques et cas récurrents observés

Au fil des années, les mêmes profils revenaient, sous des visages différents :
– des enfants brillants brusquement bloqués dans leur parcours ;
– des adultes prisonniers de rêves récurrents, de peurs nocturnes, de sensations de poursuite invisible ;
– des femmes victimes de persécutions mystiques, accusées ou se sentant accusées sans preuve ;
– des familles entières frappées par des répétitions d'échecs, de maladies, de morts prématurées ;
– des croyants fervents le jour, mais liés la nuit à des pratiques secrètes ou héritées.

Ces situations, lorsqu'elles étaient traitées uniquement par des discours moralisateurs, des prières non discernées ou des approches médicales strictement biomédicales, connaissaient rarement une guérison durable. Les rechutes étaient fréquentes, la culpabilité s'intensifiait, et la dépendance au thérapeute ou au leader spirituel devenait parfois plus lourde que le mal initial.

Ces expériences cliniques ont progressivement révélé la nécessité d'un **regard neuf**, capable de nommer les réalités spirituelles sans les diaboliser, de les analyser sans les banaliser, et de les traiter sans dominer la personne.

### Besoin urgent de formalisation thérapeutique

Face à la répétition des mêmes souffrances et à l'improvisation des réponses, l'urgence d'une **formalisation thérapeutique** s'est imposée. Il ne suffisait plus de « faire au cas par cas », ni de s'appuyer uniquement sur l'intuition ou l'expérience individuelle. Il fallait écrire, structurer, transmettre, sécuriser.

Ce livre est donc né d'un double souci :
– **protéger les patients**, trop souvent exposés à des pratiques dangereuses, confuses ou abusives ;
– **protéger les thérapeutes et accompagnateurs**, livrés à eux-mêmes, sans cadre clair, sans repères éthiques et sans outils d'évaluation.

Le **Protocole Thérapeutique de la MTHS** se présente ainsi comme une réponse mûrie, responsable et profondément humaine à une souffrance longtemps ignorée ou mal traitée.

## 2. PROBLEMATIQUE CENTRALE

### Invisibilisation des maladies spirituelles

Dans le monde contemporain, les maladies spirituelles sont soit niées, soit reléguées au rang de superstition. Cette invisibilisation produit un double effet pervers : d'une part, elle prive les personnes souffrantes de reconnaissance et de soin ; d'autre part, elle laisse le champ libre à des pratiques extrêmes, clandestines ou violentes.

En Afrique, cette invisibilisation est particulièrement paradoxale. Les sociétés reconnaissent intuitivement l'existence de l'invisible, mais hésitent à l'intégrer dans des cadres thérapeutiques sérieux. Le résultat est une souffrance silencieuse, vécue dans la honte, la peur ou la solitude, parfois jusqu'à l'effondrement psychique ou social.

## Confusion entre pathologies psychiques, sociales et spirituelles

L'un des nœuds majeurs de la problématique est la **confusion des registres**. Des troubles spirituels sont traités comme des maladies mentales ; des détresses sociales sont spiritualisées à outrance ; des troubles psychiques sont attribués à la sorcellerie sans discernement.

Cette confusion entraîne des erreurs de diagnostic, des traitements inadaptés et parfois des drames humains. La MTHS propose précisément une **lecture différentielle**, capable de distinguer sans séparer, d'articuler sans confondre. Elle reconnaît l'interaction entre le psychique, le social et le spirituel, tout en respectant la spécificité de chaque dimension.

## Souffrances silencieuses des victimes de sorcellerie et persécutions mystiques

Les victimes de sorcellerie et de persécutions mystiques vivent souvent dans une double peine : la souffrance elle-même et l'impossibilité d'en parler. Elles craignent d'être prises pour folles,

manipulées, ou accusées à leur tour. Beaucoup intériorisent la douleur jusqu'à l'épuisement.

Ce livre se veut une **voix pour ces silences**, non pour attiser la peur, mais pour ouvrir un chemin de compréhension, de guérison et de libération responsable.

## 3. OBJECTIFS DU PROTOCOLE THERAPEUTIQUE MTHS

### Offrir un cadre de diagnostic spirituel rigoureux

Le premier objectif du protocole est d'offrir un **diagnostic spirituel structuré**, fondé sur l'écoute, l'observation, l'analyse des récits, des rêves, des symptômes et du contexte familial et communautaire. Ce diagnostic ne se précipite pas vers des conclusions spectaculaires ; il avance avec prudence, humilité et méthode.

Il permet de qualifier la nature du handicap spirituel, son origine probable, son degré d'impact et les risques associés, afin d'éviter toute improvisation.

### Structurer les étapes de prise en charge

La guérison spirituelle n'est pas un événement instantané, mais un **processus**. Le protocole structure les étapes de ce processus : accueil, diagnostic, discernement, désenvoûtement, délivrance, restauration, suivi. Chaque étape a ses objectifs, ses outils, ses limites.

Cette structuration protège le patient des excès et le thérapeute de l'illusion de toute-puissance.

### Sécuriser le patient et le thérapeute

Un protocole clair sécurise les deux parties. Le patient sait à quoi s'attendre, comprend le sens des démarches, conserve sa liberté. Le thérapeute agit dans un cadre reconnu, éthique et supervisable, limitant les risques d'abus, d'épuisement ou de dérive.

### Favoriser la guérison durable et la restauration spirituelle

L'objectif ultime n'est pas la simple disparition des symptômes, mais la **restauration de la souveraineté spirituelle** de la personne. Une guérison durable se reconnaît à la paix intérieure, à la clarté du discernement, à la liberté retrouvée et à la capacité de vivre sa foi sans peur ni dépendance.

## 4. PUBLIC CIBLE DE L'OUVRAGE

### Thérapeutes traditionnels et praticiens spirituels

Le livre s'adresse en priorité aux thérapeutes de terrain, souvent démunis face à la complexité des cas. Il leur offre des repères, un langage commun, une méthode transmissible, sans nier la richesse de leurs savoirs.

### Leaders religieux et accompagnateurs spirituels

Pasteurs, prêtres, catéchistes, responsables communautaires y trouveront des outils pour mieux discerner, orienter et accompagner, sans réduire la souffrance spirituelle à un problème moral ou à un simple manque de foi.

### Chercheurs, anthropologues, médecins ouverts à l'approche holistique

Ce protocole s'inscrit dans une démarche de dialogue interdisciplinaire. Il invite les chercheurs à considérer la MTHS comme un champ d'étude sérieux, porteur d'innovations pour la santé intégrale.

### Familles et victimes de handicaps spirituels

Enfin, le livre s'adresse aux familles et aux victimes elles-mêmes, pour leur offrir des clés de compréhension, restaurer l'espérance et briser l'isolement.

## 5. POSITIONNEMENT ETHIQUE ET SPIRITUEL

### Refus de la manipulation mystique

La MTHS se positionne clairement contre toute forme de manipulation, de peur entretenue, de domination spirituelle ou financière. Le soin n'est jamais un moyen de contrôle.

## Respect de la dignité humaine

Chaque personne est considérée comme sujet, jamais comme objet. Le consentement, l'écoute et la confidentialité sont des piliers non négociables.

## Centralité de Dieu et rejet des pactes obscurs

La MTHS s'enracine dans une foi chrétienne claire, refusant tout compromis avec des pactes obscurs ou des pratiques contraires à la dignité humaine. La guérison véritable vient de Dieu et respecte la liberté.

## Encadrement strict des pratiques thérapeutiques

Enfin, ce protocole appelle à un encadrement rigoureux, à la formation continue, à la supervision et à l'évaluation, afin que la MTHS demeure un instrument de vie et non de confusion.

**Cet Avant-propos est une porte d'entrée.**

Il invite le lecteur à un chemin exigeant, humble et libérateur. Ce protocole n'est pas une fin, mais un commencement : celui d'une médecine spirituelle africaine responsable, incarnée et au service de la paix intérieure et communautaire.

L'2D

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

## *Aux seuils invisibles de la souffrance humaine et de la guérison intégrale*

Dans l'histoire des peuples d'Afrique noire, la souffrance n'a jamais été réduite à une simple défaillance du corps. Elle a toujours été perçue comme un langage, parfois obscur, parfois violent, par lequel l'être humain exprime une rupture plus profonde que la douleur physique elle-même. Cette rupture touche l'âme, l'esprit, la mémoire, la lignée et le lien au sacré. C'est dans cet espace invisible, souvent ignoré par les approches biomédicales modernes, que se déploie ce que la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels désigne comme le handicap spirituel.

Le handicap spirituel n'est pas une invention récente, ni une construction idéologique. Il est une réalité vécue, observée, transmise et soignée depuis des siècles dans les sociétés africaines, bien avant l'introduction de la médecine occidentale. Toutefois, la modernité, la colonisation des savoirs, la diabolisation des traditions africaines et certaines dérives religieuses ont contribué à rendre ce champ confus, dangereux ou suspect. Le présent ouvrage s'inscrit dans une volonté de clarification, de structuration et de restauration d'un savoir thérapeutique ancien, éclairé par la théologie chrétienne et soumis à une rigueur clinique contemporaine.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, telle que pratiquée et enseignée au sein de l'Association Mariale d'Abili, ne se situe ni dans la magie, ni dans l'occultisme, ni dans une religiosité émotionnelle incontrôlée. Elle s'inscrit dans une vision intégrale de l'être humain, où le corps, l'âme et l'esprit forment une unité indissociable. Elle reconnaît l'existence du monde invisible sans en faire un spectacle, et elle traite la souffrance spirituelle avec le même sérieux que la médecine traite les pathologies organiques.

## 1. Définition du handicap spirituel

Le handicap spirituel peut être défini comme un état durable de limitation, de perturbation ou de désorganisation de la vie spirituelle d'un individu, ayant des répercussions directes sur son équilibre psychique, relationnel, social et parfois somatique. Il se distingue clairement d'une simple difficulté morale, d'un péché personnel ou d'un trouble psychologique isolé. Il s'agit d'un état profond, souvent ancien, qui entrave la capacité de la personne à vivre pleinement, à se projeter, à prier, à aimer et à exercer sa liberté intérieure.

Les origines du handicap spirituel sont multiples. Elles peuvent être liées à l'histoire personnelle du sujet, à des traumatismes précoces, à des initiations subies, à des alliances familiales anciennes, à des pratiques rituelles non maîtrisées ou à des agressions spirituelles conscientes ou inconscientes. Dans de nombreux cas, le sujet n'a aucune connaissance de l'événement

fondateur de sa souffrance. Il en subit simplement les conséquences, parfois toute sa vie.

Les manifestations du handicap spirituel sont variables. Elles peuvent prendre la forme d'échecs répétés sans cause apparente, de maladies chroniques résistantes aux traitements, de troubles du sommeil persistants, de peurs irrationnelles, de cauchemars récurrents, de pertes de mémoire sélectives, de stérilité inexpliquée ou de ruptures relationnelles systématiques. Sur le plan invisible, elles se traduisent par un sentiment de vide intérieur, une incapacité à entrer en relation avec le sacré, une fatigue spirituelle profonde ou une impression constante d'être empêché.

Il est essentiel de distinguer le handicap spirituel de la possession et de l'oppression. La maladie spirituelle correspond à un déséquilibre interne, souvent progressif, qui affaiblit la personne sans annihiler sa volonté. L'oppression spirituelle résulte de pressions externes répétées, souvent nocturnes, qui perturbent la vie du sujet sans prendre le contrôle de sa conscience. La possession, quant à elle, implique une prise de contrôle partielle ou totale de la volonté par une entité étrangère. Elle demeure rare et requiert un discernement théologique strict. Toute confusion entre ces états constitue une faute thérapeutique grave.

## 2. Typologie des maladies et persécutions spirituelles

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels identifie plusieurs formes de maladies et de persécutions

spirituelles, chacune nécessitant une approche spécifique. La sorcellerie familiale et communautaire figure parmi les plus répandues. Elle s'inscrit dans des dynamiques relationnelles marquées par la jalousie, la rivalité, la peur de l'élévation d'autrui ou la transgression des équilibres sociaux traditionnels. Lorsqu'elle s'exerce au sein de la famille, elle est particulièrement destructrice, car elle agit dans un espace de confiance et de filiation.

Les attaques mystiques nocturnes constituent une autre forme majeure de persécution spirituelle. Elles se manifestent par des rêves répétitifs de poursuite, de chute, de combat ou de relations imposées, accompagnés d'une fatigue intense au réveil. Dans les traditions africaines comme dans les Écritures bibliques, la nuit est reconnue comme un espace de vulnérabilité spirituelle. Ces attaques ne doivent jamais être réduites à de simples troubles du sommeil sans discernement approfondi.

Les blocages spirituels chroniques se caractérisent par une stagnation persistante de la vie malgré les efforts personnels, les compétences et les opportunités. Ils concernent souvent les domaines du mariage, du travail, de la fécondité ou de la vocation. Ces blocages traduisent l'existence de verrous spirituels anciens, parfois liés à des engagements inconscients ou à des paroles performatives négatives.

Les malédictions ancestrales relèvent de la mémoire spirituelle des lignées. Elles ne sont ni automatiques ni irréversibles, mais elles produisent des schémas répétitifs de souffrance tant

qu'elles ne sont pas reconnues et traitées. La Bible elle-même atteste de ces réalités, tout en affirmant la possibilité de leur rédemption par une démarche de justice, de repentance et de restauration.

Enfin, les liens d'alliance négative et les pactes inconscients constituent l'une des causes les plus méconnues du handicap spirituel. Ils peuvent résulter de rites accomplis à la naissance, de promesses formulées au nom de l'enfant, de noms porteurs de charges spirituelles lourdes ou de dédicaces familiales jamais expliquées. La MTHS enseigne que toute libération authentique commence par la révélation et la compréhension.

## 3. Fondements théologiques et traditionnels de la MTHS

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels s'appuie sur une vision théologique solide de la guérison. Dans la tradition biblique, la guérison est toujours intégrale. Jésus ne se contente pas de soulager les symptômes ; il restaure la personne dans sa dignité, sa liberté et sa relation à Dieu. La délivrance n'est jamais un acte de violence, mais un acte d'autorité aimante, ordonnée et respectueuse.

La tradition africaine authentique apporte une compréhension fine des dynamiques invisibles. Elle reconnaît l'interconnexion entre les vivants et les morts, entre l'individu et la communauté, entre le corps et l'esprit. Le thérapeute traditionnel y occupe une place de médiateur, soumis à des règles éthiques

strictes. La MTHS ne rejette pas cette sagesse, mais elle la discerne, l'épure et l'oriente vers la vie.

Un discernement rigoureux s'impose toutefois entre tradition thérapeutique et pratiques occultes. Toute pratique fondée sur la domination, la peur, la manipulation ou le sacrifice est exclue du champ thérapeutique. La MTHS pose des critères clairs de légitimité spirituelle, fondés sur le respect de la personne humaine et la recherche de la liberté intérieure.

## 4. Nécessité d'un protocole thérapeutique structuré

L'une des grandes dérives contemporaines réside dans les pratiques empiriques non encadrées. Les délivrances improvisées, les diagnostics hâtifs et les rituels violents produisent des traumatismes durables. La souffrance spirituelle ne peut être traitée dans l'urgence émotionnelle ou l'improvisation.

Un protocole structuré garantit la sécurité spirituelle et clinique du patient. Il permet d'évaluer les risques, de respecter le rythme de la personne et d'éviter les dépendances thérapeutiques. La traçabilité des soins et le suivi constituent des exigences éthiques fondamentales de la MTHS.

## 5. Présentation générale du protocole MTHS

Le protocole MTHS repose sur des principes directeurs clairs : respect absolu de la personne, discernement spirituel, progressivité thérapeutique et collaboration interdisciplinaire. Il se

déploie en cinq étapes : le diagnostic spirituel et anthropologique, le traitement préparatoire, la libération encadrée, la restauration intérieure et le suivi de consolidation.

Plusieurs acteurs peuvent intervenir dans ce processus : le thérapeute MTHS, l'accompagnateur spirituel, les référents communautaires et, lorsque nécessaire, des professionnels de santé. Le thérapeute agit dans des limites claires. Il n'est ni un sauveur ni un devin, mais un serviteur de la guérison.

## 6. Méthodologie et organisation de l'ouvrage

Cet ouvrage est structuré selon une logique progressive. Chaque chapitre conduit le lecteur de la compréhension théorique à l'intégration pratique. Les cas cliniques présentés sont anonymisés et visent exclusivement la formation du discernement. La finalité de ce livre est pédagogique, thérapeutique et spirituelle. Il ne cherche ni à effrayer ni à impressionner, mais à éclairer, restaurer et responsabiliser.

Entrer dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, c'est accepter de marcher avec humilité sur un territoire sacré. Ce chemin exige patience, rigueur et compassion. Il ne promet pas des solutions immédiates, mais une restauration profonde et durable de l'être humain dans toutes ses dimensions.

# PARTIE- I:

# PROTOCOLE DU DIAGNOSTIC CLINIQUE DE LA MTHS

# CHAPITRE- I :

# CADRE CONCEPTUEL DU DIAGNOSTIC EN MTHS

***Entrer dans l'intelligence spirituelle de la souffrance humaine***

Diagnostiquer, en Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, n'est jamais un acte banal. Il ne s'agit ni de nommer rapidement une souffrance, ni d'apposer une étiquette rassurante ou spectaculaire sur une vie blessée. Le diagnostic MTHS est un **acte de responsabilité**, un **acte de discernement**, et parfois même un **acte de réparation symbolique**, par lequel une souffrance longtemps muette reçoit enfin un langage compréhensible.

Dans les sociétés africaines traditionnelles, le diagnostic n'a jamais été séparé de la sagesse. Celui qui diagnostique ne se contente pas d'observer ; il écoute, il relie, il interprète, il prie. Il se tient à la frontière du visible et de l'invisible, conscient que toute erreur de discernement peut aggraver la souffrance au lieu de la soulager. La MTHS s'inscrit pleinement dans cette éthique ancienne, tout en l'inscrivant dans un cadre théologique et clinique rigoureux.

Ce chapitre pose donc les fondements conceptuels indispensables à tout diagnostic MTHS authentique. Il clarifie les notions, distingue les registres de souffrance, expose la vision holistique africaine de la personne humaine, précise la place

centrale du discernement spirituel et rappelle avec force les limites éthiques et scientifiques de cette approche.

## 1. Définition du handicap spirituel

Le handicap spirituel constitue le cœur conceptuel de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels. Il désigne un état durable ou récurrent dans lequel la capacité spirituelle d'un individu est entravée, désorganisée ou neutralisée, affectant profondément son rapport à lui-même, aux autres, au monde et au sacré. Contrairement à une crise spirituelle passagère, le handicap spirituel s'inscrit dans le temps, souvent de manière chronique, et résiste aux solutions ordinaires.

Dans l'anthropologie africaine, l'être humain est porteur d'une force vitale appelée à circuler harmonieusement entre le corps, l'âme et l'esprit. Lorsque cette circulation est bloquée, détournée ou capturée, l'individu entre dans un état de vulnérabilité profonde. Le handicap spirituel est précisément cette **entrave à la circulation de la vie**, qui peut avoir des causes multiples : héritages ancestraux non assumés, agressions mystiques, pactes inconscients, transgressions symboliques, ruptures rituelles ou traumatismes spirituels.

Ce handicap ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. Il agit souvent en silence, par usure progressive. Le sujet concerné peut mener une vie extérieurement normale tout en ressentant intérieurement une fatigue inexpliquée, une incapacité à

se projeter, une perte de sens, une stérilité existentielle ou une répétition inexorable des échecs. Dans de nombreux cas, la personne a consulté médecins, psychologues, pasteurs ou tradipraticiens sans qu'une réponse satisfaisante ne soit trouvée.

La MTHS considère que le handicap spirituel n'est jamais une condamnation définitive. Il est un état réversible, à condition qu'il soit reconnu, compris et traité avec discernement. Mais cette reconnaissance suppose un diagnostic précis, respectueux et éclairé.

## 2. Différence entre trouble spirituel, psychique et social

L'une des premières exigences du diagnostic MTHS est la capacité à distinguer clairement les différents registres de souffrance. La confusion entre trouble spirituel, trouble psychique et trouble social constitue l'une des causes majeures de dérives thérapeutiques, tant dans certains milieux religieux que dans certaines pratiques traditionnelles non encadrées.

Le **trouble psychique** relève principalement du fonctionnement de la psyché. Il peut être lié à des traumatismes, à des déséquilibres neurobiologiques, à des troubles de l'humeur ou à des pathologies psychiatriques identifiées. Il nécessite une prise en charge spécialisée, souvent médicale et psychothérapeutique. La MTHS reconnaît pleinement la légitimité de ces approches et refuse toute prétention de substitution.

Le **trouble social**, quant à lui, résulte de conditions de vie précaires, de violences structurelles, de conflits familiaux, de marginalisation ou de ruptures relationnelles. Il produit une souffrance réelle, parfois intense, mais dont les causes sont essentiellement environnementales. Traiter spirituellement une souffrance sociale sans agir sur les conditions matérielles relève d'une grave erreur éthique.

Le **trouble spirituel**, enfin, touche la dimension la plus profonde de l'être. Il se manifeste lorsque la relation au sacré, à la transcendance, à la mémoire ancestrale ou à la vocation intérieure est altérée. Ce trouble peut coexister avec des troubles psychiques ou sociaux, mais il ne s'y réduit jamais. Le diagnostic MTHS consiste précisément à discerner si la souffrance principale relève de ce registre, ou si elle en constitue une conséquence secondaire.

Cette distinction n'est jamais mécanique. Elle exige une écoute patiente, une observation fine et une humilité constante. Le thérapeute MTHS ne cherche pas à tout expliquer spirituellement. Il cherche à comprendre ce qui, dans la souffrance exprimée, relève véritablement du handicap spirituel.

### 3. Vision holistique africaine du corps, de l'âme et de l'esprit

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels s'enracine dans une vision holistique de l'être humain, héritée des grandes traditions africaines. Dans cette vision, le corps, l'âme et

l'esprit ne sont pas des entités séparées, mais des dimensions interdépendantes d'une même réalité vivante.

Le corps est le lieu d'inscription de l'histoire personnelle et collective. Il porte les marques visibles et invisibles des alliances, des ruptures et des traumatismes. L'âme est le siège de la mémoire, des émotions, des désirs et des blessures relationnelles. L'esprit, enfin, est le lieu du souffle vital, de la relation à Dieu, aux ancêtres et au sens ultime de l'existence.

Dans cette anthropologie, toute atteinte spirituelle finit par s'inscrire dans le corps et l'âme. Inversement, toute blessure corporelle ou psychique prolongée finit par fragiliser la vie spirituelle. C'est pourquoi la MTHS refuse toute approche fragmentée de la personne humaine.

Le diagnostic MTHS s'appuie sur cette vision intégrale. Il observe les symptômes corporels sans les isoler de leur contexte spirituel. Il écoute les récits de vie comme des récits symboliques, porteurs de sens. Il considère les rêves, les répétitions biographiques et les blocages existentiels comme des indices, jamais comme des preuves absolues.

Cette approche holistique trouve un écho profond dans la théologie chrétienne, qui reconnaît l'unité de la personne humaine et la nécessité d'une guérison intégrale. L'inculturation du christianisme en Afrique noire permet ainsi une convergence féconde entre foi chrétienne et sagesse ancestrale.

## 4. Place du discernement spirituel dans l'acte diagnostique

Le discernement spirituel constitue le cœur du diagnostic MTHS. Il ne s'agit ni d'une intuition vague, ni d'un don spectaculaire, mais d'une compétence spirituelle qui se cultive par la prière, l'expérience, l'étude et l'humilité. Le discernement permet de distinguer ce qui relève de l'imaginaire, du psychisme, du social ou du spirituel proprement dit.

Dans la tradition biblique, le discernement est présenté comme un don de l'Esprit, mais aussi comme une responsabilité humaine. Il exige une posture intérieure de disponibilité, de silence et de respect. Le thérapeute MTHS ne cherche pas à impressionner le patient par des révélations. Il cherche à éclairer progressivement la situation, en laissant émerger la vérité au rythme de la personne accompagnée.

Le discernement s'exerce à plusieurs niveaux : discernement des symptômes, discernement de l'histoire personnelle, discernement des héritages familiaux, discernement des influences spirituelles. Il s'appuie sur des signes convergents, jamais sur un seul élément isolé.

Toute précipitation diagnostique constitue une faute grave. Nommer trop vite un handicap spirituel peut enfermer la personne dans une identité de victime et renforcer sa dépendance. Le discernement authentique, au contraire, ouvre un chemin de responsabilisation et de liberté.

## 5. Limites du diagnostic de la MTHS : non-substitution à la médecine moderne

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels affirme avec clarté ses limites. Elle ne se substitue ni à la médecine moderne, ni à la psychiatrie, ni à la psychologie clinique. Elle intervient dans un champ spécifique, celui de la souffrance spirituelle, et reconnaît la nécessité d'une collaboration interdisciplinaire.

Tout diagnostic MTHS doit être précédé ou accompagné, lorsque cela est nécessaire, d'examens médicaux appropriés. Ignorer une pathologie organique au profit d'une interprétation spirituelle constitue une mise en danger du patient. De même, nier l'existence d'un trouble psychiatrique avéré au nom d'une lecture spirituelle est une dérive grave.

La MTHS repose sur une éthique de responsabilité. Le thérapeute est tenu de référer le patient à d'autres professionnels lorsque la situation l'exige. Cette humilité constitue un signe de maturité spirituelle et non de faiblesse.

En posant clairement ses limites, le diagnostic MTHS se protège contre les abus et gagne en crédibilité. Il devient un outil de discernement au service de la vie, et non un instrument de pouvoir.

## Conclusion

Le cadre conceptuel du diagnostic MTHS repose sur une vision exigeante de l'être humain et de la souffrance. Il invite le thérapeute comme le lecteur à une posture de respect, de lenteur et de profondeur. Diagnostiquer, en MTHS, ce n'est pas désigner un coupable invisible, mais ouvrir un espace de compréhension et de guérison.

Ce premier chapitre pose les fondations sur lesquelles reposera l'ensemble du parcours thérapeutique. Il rappelle que toute véritable guérison commence par une parole juste, prononcée dans la vérité, la compassion et le discernement.

# CHAPITRE- II :
# TYPOLOGIE DES HANDICAPS SPIRITUELS

## *Cartographie clinique et spirituelle des entraves invisibles de l'âme humaine*

Toute souffrance spirituelle ne se ressemble pas. Toute entrave invisible n'a ni la même origine, ni la même profondeur, ni les mêmes conséquences. L'une des erreurs majeures des pratiques spirituelles empiriques réside dans la généralisation abusive : vouloir traiter toutes les détresses spirituelles de la même manière, avec les mêmes prières, les mêmes rites ou les mêmes diagnostics hâtifs.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels refuse cette simplification dangereuse. Elle enseigne que **la guérison commence par la reconnaissance de la singularité du handicap**, par l'identification précise de son mode d'installation, de sa dynamique interne et de ses effets sur la personne et son environnement. Ce chapitre propose une typologie structurée des handicaps spirituels, non comme une classification rigide, mais comme une **boussole clinique et théologique**, destinée à éclairer le discernement.

À travers ces typologies, le lecteur est invité à descendre progressivement dans les couches profondes de la souffrance humaine, là où la peur, les pactes, les initiations, les dépendances

et les confusions spirituelles façonnent des vies entravées, parfois dès l'enfance, parfois à l'échelle d'une communauté entière.

## 1. Handicap spirituel par peur

Le handicap spirituel par peur est l'un des plus répandus et paradoxalement l'un des moins reconnus. Il s'installe souvent de manière insidieuse, sans événement spectaculaire, mais avec une puissance destructrice considérable. La peur, dans ce contexte, n'est pas une émotion passagère. Elle devient une **structure intérieure**, un principe organisateur de la vie spirituelle.

Dans de nombreuses sociétés africaines, la peur est transmise très tôt : peur des ancêtres offensés, peur des esprits, peur de la malédiction, peur de sortir du cadre communautaire, peur d'échouer là où d'autres ont échoué. Lorsqu'elle n'est pas accompagnée, expliquée et ritualisée de manière saine, cette peur devient un terrain fertile pour le handicap spirituel.

Cliniquement, le handicap par peur se manifeste par une paralysie intérieure. Le sujet évite les décisions importantes, redoute toute initiative, vit dans une attente anxieuse de catastrophes invisibles. Spirituellement, il développe une relation au sacré fondée sur la crainte plutôt que sur la confiance. La prière devient défensive, obsessionnelle, parfois compulsive. Dieu n'est plus perçu comme un Père, mais comme une instance punitive imprévisible.

Dans la perspective chrétienne inculturée, ce type de handicap révèle une distorsion grave de l'image de Dieu. La théologie de la délivrance rappelle que « la crainte n'est pas dans l'amour » et que toute peur qui paralyse la liberté intérieure doit être discernée et soignée. La MTHS aborde ce handicap par un travail progressif de restauration de la confiance spirituelle, en déconstruisant les peurs héritées et en rétablissant une relation pacifiée au sacré.

### 2. Handicap spirituel par pacte (volontaire ou hérité)

Le handicap spirituel par pacte constitue l'une des formes les plus complexes et les plus délicates à diagnostiquer. Le pacte, dans l'anthropologie africaine, n'est pas nécessairement un acte conscient de sorcellerie. Il peut être explicite ou implicite, volontaire ou hérité, personnel ou collectif. Il s'agit toujours d'un **engagement spirituel liant**, souvent contracté en échange d'une protection, d'un pouvoir, d'une survie ou d'une reconnaissance.

Les pactes volontaires sont parfois contractés dans des contextes de détresse extrême : maladie grave, pauvreté, stérilité, échec répété. Ils peuvent prendre la forme de serments, d'offrandes, de promesses faites à une entité spirituelle ou à un intermédiaire humain. Ces pactes créent une dépendance spirituelle durable, dont le prix se révèle souvent bien plus lourd que le bénéfice initial.

Les pactes hérités, quant à eux, sont transmis à l'insu du sujet. Ils résultent de décisions prises par des ancêtres, des parents ou des lignées entières. L'enfant naît alors dans un champ d'obligations invisibles qu'il ne comprend pas, mais dont il subit les conséquences. Blocages répétitifs, maladies récurrentes, impossibilité de rompre avec certains schémas familiaux sont autant de signes de ces pactes non résolus.

La théologie chrétienne reconnaît l'existence de ces liens spirituels transmis, tout en affirmant leur possible rédemption. La MTHS insiste sur une approche respectueuse et progressive. Briser un pacte sans le comprendre expose à des déséquilibres graves. La libération véritable passe par la vérité, la renonciation consciente et la restauration de la liberté intérieure.

### 3. Handicap spirituel par initiation contrainte

L'initiation, dans les cultures africaines traditionnelles, est à l'origine un processus structurant, destiné à intégrer l'individu dans la communauté et à lui transmettre des savoirs essentiels. Toutefois, lorsque l'initiation est imposée, détournée ou instrumentalisée, elle devient une source majeure de handicap spirituel. L'initiation contrainte peut survenir dans différents contextes : rites accomplis sans consentement, rêves initiatiques non accompagnés, maladies interprétées comme des appels spirituels sans discernement, ou encore intégration forcée dans des sociétés initiatiques fermées. Dans ces cas, l'individu ne choisit pas son chemin spirituel ; il le subit.

Cliniquement, ce type de handicap se manifeste par des conflits intérieurs profonds, une sensation de dédoublement, une instabilité identitaire et une grande fatigue spirituelle. Le sujet peut se sentir « habité » par une vocation qu'il n'a jamais désirée, ou au contraire rejetée par une force qu'il ne comprend pas.

La MTHS distingue soigneusement l'appel spirituel authentique de l'initiation pathologique. La théologie chrétienne rappelle que Dieu n'appelle jamais par la violence ni par la contrainte. Toute initiation qui détruit la liberté intérieure est suspecte. Le travail thérapeutique vise ici à restaurer le libre arbitre, à désamorcer les contraintes invisibles et à permettre à la personne de se réapproprier son chemin spirituel.

### 4. Handicap spirituel par dépendance religieuse ou mystique

La dépendance religieuse ou mystique constitue une forme subtile et socialement valorisée de handicap spirituel. Elle se développe lorsque la relation au sacré devient une relation de dépendance excessive à un leader, à un groupe, à un rituel ou à une pratique spirituelle spécifique.

Dans ce type de handicap, la personne n'existe plus spirituellement par elle-même. Elle ne peut prier sans médiation abusive, décider sans autorisation spirituelle, agir sans validation mystique. Toute autonomie est vécue comme une trahison ou un danger. Cette dépendance est souvent entretenue par des discours culpabilisants ou apocalyptiques.

Cliniquement, le sujet présente une anxiété intense à l'idée de quitter le groupe ou de remettre en question l'autorité spirituelle. Spirituellement, la foi devient un espace de contrôle plutôt que de libération. La relation à Dieu est médiatisée par la peur de perdre la protection spirituelle promise.

La MTHS considère ce type de handicap comme une aliénation spirituelle. La théologie chrétienne de la liberté rappelle que toute autorité spirituelle authentique conduit à l'autonomie responsable, non à la soumission infantilisante. Le processus thérapeutique consiste à restaurer la capacité de discernement personnel et la relation directe, mature et libre au sacré.

### 5. Handicap spirituel par syncrétisme pathologique

Le syncrétisme pathologique résulte d'un mélange non discerné de systèmes spirituels incompatibles, générant une confusion profonde dans la vie intérieure du sujet. Contrairement à l'inculturation, qui intègre harmonieusement les valeurs culturelles dans la foi chrétienne, le syncrétisme pathologique juxtapose des pratiques contradictoires sans cohérence théologique ni anthropologique.

Ce type de handicap apparaît souvent chez des personnes en quête de solutions rapides, cumulant prières chrétiennes, rites traditionnels, pratiques ésotériques et consultations multiples. Cette accumulation crée une surcharge spirituelle, affaiblissant les

défenses intérieures et ouvrant la porte à des influences contradictoires.

Cliniquement, le sujet présente une grande instabilité spirituelle, passant d'un système de croyance à un autre, sans jamais trouver la paix. Les symptômes s'aggravent malgré l'intensification des pratiques. La confusion devient chronique.

La MTHS insiste sur la nécessité d'un choix spirituel clair et cohérent. L'inculturation authentique suppose un discernement rigoureux, respectueux des cultures africaines, mais fidèle à l'Évangile. Le travail thérapeutique vise à purifier la foi, à restaurer l'unité intérieure et à mettre fin aux alliances contradictoires.

### 6. Handicap spirituel collectif et communautaire

Enfin, il existe des handicaps spirituels qui ne concernent pas seulement des individus, mais des familles, des clans, des villages ou même des institutions. Ces handicaps collectifs résultent de traumatismes historiques, de violences non réparées, de pactes communautaires anciens ou de transgressions collectives.

Ils se manifestent par des schémas répétitifs : conflits permanents, échecs structurels, maladies récurrentes, stagnation collective, exode des jeunes générations. Aucun individu n'en est directement responsable, mais tous en subissent les effets.

La MTHS reconnaît la dimension communautaire de la guérison. Certains handicaps ne peuvent être résolus qu'à travers

des démarches collectives de reconnaissance, de réparation symbolique et de restauration des liens. La théologie biblique elle-même reconnaît la responsabilité collective et la possibilité de guérison communautaire.

## Conclusion

Cette typologie des handicaps spirituels ne vise pas à enfermer les personnes dans des catégories figées. Elle offre une grille de lecture, un outil de discernement et une invitation à la profondeur. Chaque handicap spirituel est une histoire singulière, un appel à la compréhension, à la compassion et à la responsabilité.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels rappelle que toute libération authentique commence par la vérité, se poursuit par le discernement et s'accomplit dans la restauration de la liberté intérieure. Ce chapitre prépare ainsi le lecteur à entrer dans les protocoles thérapeutiques, avec une conscience élargie de la complexité et de la dignité de toute souffrance humaine.

# CHAPITRE- III :
# SYMPTÔMES CLINIQUES EN MTHS

***Quand l'invisible parle à travers le corps, l'âme et la vie sociale***

Toute souffrance spirituelle cherche un langage. Lorsqu'elle ne peut être dite, elle se montre. Lorsqu'elle n'est pas comprise, elle s'inscrit dans le corps, dans la pensée, dans les relations et dans le destin. En Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, le symptôme n'est jamais un simple dysfonctionnement à éliminer ; il est un **message**, parfois confus, parfois violent, mais toujours porteur d'un sens profond.

Ce chapitre constitue une étape décisive du parcours thérapeutique. Il apprend à **lire les signes**, à reconnaître les manifestations visibles et invisibles du handicap spirituel, sans précipitation ni interprétation abusive. La MTHS enseigne que la justesse du diagnostic dépend largement de la capacité à discerner les symptômes dans leur globalité, à comprendre leur cohérence interne et à évaluer leur gravité réelle.

Dans la tradition africaine, le symptôme n'est jamais isolé de l'histoire de la personne. Il est relié à son parcours, à sa lignée, à son environnement et à son rapport au sacré. De même, la théologie chrétienne reconnaît que la souffrance humaine s'exprime sur plusieurs plans simultanés : spirituel, psychique, corporel et social. C'est à cette lecture intégrale que ce chapitre invite.

## 1. Symptômes spirituels : confusion, oppression et rupture intérieure

Les symptômes spirituels constituent le noyau central du handicap spirituel. Ils sont souvent les plus difficiles à identifier, car ils ne disposent pas toujours d'un langage reconnu dans les cadres médicaux ou psychologiques classiques. Pourtant, ce sont eux qui orientent prioritairement le discernement MTHS.

La **confusion spirituelle** est l'un des premiers signes. Elle se manifeste par une perte de repères intérieurs : la personne ne sait plus ce qu'elle croit, ce qu'elle doit faire, ni vers qui se tourner. La prière devient incohérente, mécanique ou angoissante. Les convictions spirituelles changent fréquemment, parfois de manière contradictoire. Le sujet peut éprouver une attirance simultanée pour des pratiques opposées, sans parvenir à unifier son chemin intérieur.

L'**oppression spirituelle** se traduit par une sensation persistante de lourdeur intérieure, d'étouffement invisible ou de pression constante. Le sujet se sent surveillé, empêché ou freiné sans cause apparente. Cette oppression s'intensifie souvent dans les moments de prière, de silence ou de décision importante. Elle peut s'accompagner d'une fatigue spirituelle profonde, d'un rejet progressif des choses sacrées ou d'une peur diffuse du monde invisible.

La **rupture intérieure** est un symptôme plus avancé. Elle correspond à une fracture entre l'âme et l'esprit, entre la foi professée et l'expérience vécue. La personne peut continuer à participer à des pratiques religieuses tout en se sentant intérieurement vide, absente ou déconnectée. Cette rupture génère un sentiment de culpabilité, de honte ou d'imposture spirituelle. Dans certains cas, elle conduit à un abandon total de la vie spirituelle.

La MTHS considère ces symptômes comme des signaux d'alarme majeurs. Ils indiquent que la circulation de la vie spirituelle est entravée et qu'un travail de discernement approfondi est nécessaire. La théologie chrétienne rappelle ici que la paix intérieure est un critère fondamental de la présence divine, et que toute spiritualité durablement marquée par la confusion et l'oppression doit être interrogée.

## 2. Symptômes psychiques associés : angoisse, dissociation et troubles du sommeil

Les symptômes spirituels s'accompagnent très souvent de manifestations psychiques. La MTHS ne les oppose jamais aux symptômes spirituels ; elle les considère comme des expressions complémentaires d'une même souffrance globale. Toutefois, elle insiste sur la nécessité d'un discernement rigoureux afin d'éviter toute confusion avec des pathologies psychiatriques autonomes.

L’**angoisse chronique** est l’un des symptômes psychiques les plus fréquents. Elle ne se limite pas à une anxiété circonstancielle, mais s’installe comme un état permanent. Le sujet vit dans une attente constante de danger, sans pouvoir identifier clairement ce qu’il redoute. Cette angoisse s’intensifie souvent la nuit ou dans les moments de solitude. Elle peut être accompagnée de palpitations, de sensations d’oppression thoracique ou de pensées catastrophiques.

La **dissociation** constitue un symptôme plus préoccupant. Elle se manifeste par une impression de déconnexion de soi-même, comme si la personne observait sa propre vie de l’extérieur. Le sujet peut éprouver des pertes de mémoire, des absences, ou une difficulté à reconnaître ses propres émotions. Dans le cadre de la MTHS, la dissociation est souvent interprétée comme un mécanisme de protection face à une surcharge spirituelle ou à des expériences intérieures non intégrées.

Les **troubles du sommeil** occupent une place centrale dans l’évaluation clinique. Cauchemars récurrents, paralysies nocturnes, réveils brutaux accompagnés de peur intense, insomnies persistantes ou fatigue chronique malgré le repos sont autant de signes à prendre au sérieux. Dans l’anthropologie africaine comme dans la Bible, la nuit est un espace de vulnérabilité spirituelle. Les perturbations nocturnes constituent donc des indicateurs précieux du niveau d’atteinte intérieure.

La MTHS insiste toutefois sur une collaboration étroite avec les professionnels de santé mentale lorsque ces symptômes deviennent envahissants. Le discernement consiste à reconnaître ce qui relève prioritairement du champ spirituel, sans jamais nier la nécessité d'une prise en charge psychologique ou psychiatrique lorsque celle-ci s'impose.

### 3. Symptômes corporels psychosomatiques

Le corps est souvent le premier lieu où la souffrance spirituelle s'inscrit de manière visible. Dans la vision holistique africaine, le corps n'est pas un simple support biologique ; il est une mémoire vivante, capable d'exprimer ce que l'âme ne parvient pas à dire. Les symptômes psychosomatiques occupent donc une place essentielle dans la clinique MTHS.

Ces symptômes se manifestent par des douleurs persistantes sans cause organique clairement identifiée : maux de tête chroniques, douleurs abdominales, lombalgies, tensions cervicales, troubles digestifs ou palpitations inexpliquées. Ils résistent souvent aux traitements médicaux classiques, ou ne répondent que de manière partielle et temporaire.

La fatigue chronique est un autre symptôme fréquent. Elle dépasse largement la simple lassitude physique. Le sujet se sent épuisé dès le réveil, incapable de mobiliser son énergie vitale. Cette fatigue est souvent décrite comme « intérieure », « profonde », « lourde », traduisant un affaiblissement global de la force vitale.

Dans certains cas, le corps devient le théâtre de manifestations plus spectaculaires : tremblements, sensations de brûlure, oppressions soudaines ou réactions corporelles lors de pratiques spirituelles. La MTHS aborde ces manifestations avec prudence, en évitant toute interprétation hâtive. Le symptôme corporel n'est jamais une preuve en soi, mais un élément parmi d'autres dans l'évaluation globale.

La théologie chrétienne rappelle ici que le corps est le temple de l'Esprit et qu'il participe pleinement au processus de guérison. Toute prise en charge spirituelle authentique doit donc inclure une écoute respectueuse du langage du corps, sans le mépriser ni l'idéaliser.

### 4. Symptômes sociaux et relationnels

Le handicap spirituel ne reste jamais confiné à la sphère intérieure. Il finit toujours par affecter la vie sociale, familiale et relationnelle du sujet. Ces symptômes sont souvent les plus visibles pour l'entourage, mais aussi les plus douloureux, car ils exposent la personne à l'incompréhension, à l'isolement et parfois à la stigmatisation.

Les **conflits relationnels récurrents** constituent un signe fréquent. Le sujet semble reproduire les mêmes schémas de rupture, quelles que soient les personnes ou les contextes. Les relations commencent souvent avec intensité, puis se dégradent

brutalement. Cette répétition traduit l'existence de dynamiques intérieures non résolues.

L'**isolement social progressif** est un autre indicateur majeur. La personne se retire peu à peu de la vie communautaire, non par choix conscient, mais par fatigue, méfiance ou sentiment de ne pas être comprise. Cet isolement renforce la souffrance spirituelle et peut conduire à une marginalisation profonde.

Les **échecs socio-professionnels répétés** doivent également être analysés avec discernement. Lorsque les compétences, les efforts et les opportunités ne produisent aucun fruit durable, malgré des tentatives multiples, la MTHS invite à interroger l'existence de blocages spirituels sous-jacents, sans jamais nier les facteurs économiques ou sociaux.

Dans les familles et les communautés, le handicap spirituel peut engendrer des tensions collectives, des divisions persistantes ou une atmosphère de conflit latent. La souffrance d'un individu devient alors le symptôme d'un déséquilibre plus large, appelant parfois une démarche communautaire de guérison.

## 5. Indicateurs de gravité et de chronicité

Tous les symptômes spirituels ne présentent pas le même degré de gravité. La MTHS distingue soigneusement les signes passagers des indicateurs de chronicité et de profondeur, afin d'adapter la prise en charge thérapeutique.

Parmi les **indicateurs de gravité**, on retrouve la précocité des symptômes, leur intensification progressive, leur résistance à toute forme d'accompagnement et leur extension à plusieurs sphères de la vie. Lorsque la souffrance touche simultanément la vie spirituelle, psychique, corporelle et sociale, le handicap est généralement ancien et profondément enraciné.

La **chronicité** se manifeste par la répétition des mêmes symptômes sur plusieurs années, parfois sur plusieurs générations. Les récits familiaux révèlent alors des schémas similaires de souffrance, d'échec ou de maladie. Ces éléments orientent le discernement vers des causes structurelles, nécessitant un travail thérapeutique de longue durée.

La MTHS insiste sur la nécessité d'une grande prudence face aux situations graves. Toute précipitation, toute promesse de guérison rapide ou toute mise en scène spectaculaire constitue une faute éthique. La guérison véritable est un processus, non un événement isolé.

## Conclusion

Les symptômes cliniques en MTHS ne sont ni des anomalies à effacer, ni des preuves à exhiber. Ils sont les **portes d'entrée d'un dialogue thérapeutique profond**, les traces visibles d'une souffrance invisible qui cherche reconnaissance et guérison. Apprendre à les lire avec discernement, humilité et compassion constitue une étape essentielle du chemin thérapeutique.

Ce chapitre prépare ainsi le lecteur à entrer dans l'élaboration des protocoles de prise en charge, en rappelant que toute libération authentique commence par une écoute attentive des signes, dans le respect absolu de la dignité humaine.

# CHAPITRE-4 :
# OUTILS DE DIAGNOSTIC CLINIQUE EN MÉDECINE TRADITIONNELLE DES HANDICAPÉS SPIRITUELS (MTHS)

## *Discerner avant d'agir*

Dans l'œuvre de guérison spirituelle, le discernement précède toujours l'action. Celui qui soigne sans avoir discerné agit dans l'ombre ; celui qui discerne avec humilité agit dans la lumière. Pour l'Association Mariale d'Abili (ASMAB), engagée au service des personnes blessées dans leur être spirituel, le diagnostic n'est ni une curiosité mystique ni une enquête intrusive : il est un **acte de charité éclairée**, une responsabilité grave confiée à des serviteurs formés, prudents et enracinés dans la foi.

En Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), diagnostiquer signifie **écouter ce que l'être humain n'arrive plus à dire**, lire ce que son corps exprime, comprendre ce que son histoire familiale porte, et surtout **discerner ce qui relève du spirituel, sans confondre ni spiritualiser abusivement la souffrance humaine**.

Ce chapitre est destiné à former la conscience et la pratique des acteurs ASMAB appelés à accompagner, orienter ou prendre en charge des personnes en détresse spirituelle. Il présente les outils fondamentaux du diagnostic MTHS, dans un langage accessible, fidèle à la tradition chrétienne, respectueux de la sagesse africaine et rigoureusement encadré.

# 1. L'entretien clinique spirituel structuré : l'art d'écouter pour guérir

## 1.1. L'entretien comme acte pastoral

L'entretien clinique spirituel est le premier outil du diagnostic MTHS. Pour un catéchiste, un religieux ou un thérapeute ASMAB, il s'apparente à un **temps d'écoute pastorale approfondie**, mais structuré, orienté et protégé. Il ne s'agit pas d'un simple échange fraternel, encore moins d'un interrogatoire, mais d'un **espace sécurisé où la personne peut déposer son fardeau**.

Dans l'Évangile, Jésus ne commence jamais par accuser ou interpréter. Il écoute, il regarde, il interroge avec douceur. L'entretien MTHS s'inscrit dans cette pédagogie du Christ : accueillir la personne telle qu'elle est, sans jugement, sans précipitation, sans promesse irréaliste.

## 1.2. Cadre et déroulement de l'entretien

Pour éviter les dérives émotionnelles ou spirituelles, l'entretien doit toujours être **structuré**, même lorsqu'il semble spontané. En contexte ASMAB, il comporte généralement :

1. **Un temps d'ouverture spirituelle**
   Prière brève, invocation de la paix du Christ, rappel de la présence de Dieu.

2. **Un temps de parole libre du patient**
   La personne raconte ce qu'elle vit, ce qui la fait souffrir, ce qu'elle ne comprend pas.

3. **Un temps de questionnement guidé**
   Le thérapeute ou accompagnateur pose des questions simples, jamais suggestives, sur :

   - la vie spirituelle,
   - l'histoire familiale,
   - les expériences religieuses passées,
   - les peurs, blocages ou répétitions douloureuses.

4. **Un temps de reformulation et de discernement**
   Ce que le praticien a compris est reformulé avec prudence, sans poser encore de diagnostic définitif.

5. **Un temps de clôture et de protection**
   Prière finale, conseils temporaires, orientation éventuelle vers un autre service (médical, psychologique, pastoral).

Cet entretien est déjà thérapeutique en lui-même, car **être écouté dans la vérité soulage l'âme**.

## 2. L'anamnèse spirituelle et généalogique : relire l'histoire à la lumière

### 2.1. Comprendre la personne dans sa lignée

Dans la culture africaine, l'individu n'est jamais isolé. Il est fils, fille, héritier d'une histoire, porteur d'une mémoire familiale parfois lourde. La MTHS enseigne que certaines souffrances spirituelles ne prennent sens qu'à la lumière de la **généalogie spirituelle**.

Pour ASMAB, cette démarche ne vise ni à culpabiliser les familles ni à condamner les ancêtres, mais à **comprendre les chaînes invisibles qui peuvent entraver une vie**.

### 2.2. Éléments explorés dans l'anamnèse

L'anamnèse spirituelle et généalogique peut aborder :

- les décès anormaux ou répétés dans la famille,
- les échecs chroniques sans cause apparente,
- les pratiques traditionnelles anciennes (rites, pactes, serments),
- les conflits familiaux persistants,
- les appels, rêves ou manifestations liés aux ancêtres.

Tout cela est recueilli avec **respect, prudence et prière**, car certaines vérités ne se révèlent que progressivement.

## 3. Lecture spirituelle des rêves et manifestations nocturnes

### 3.1. Le rêve : un langage à discerner

Pour beaucoup de personnes accompagnées par ASMAB, les rêves sont une source de peur et de confusion. La MTHS enseigne que le rêve peut être :

- un simple produit psychique,
- un message symbolique,
- ou un espace de combat spirituel.

Le rôle du thérapeute n'est pas d'interpréter systématiquement, mais de **discerner avec sagesse**.

### 3.2. Règles de discernement de la MTHS

En MTHS, la lecture des rêves obéit à des règles simples :

- aucun rêve ne fonde à lui seul un diagnostic,
- les rêves doivent être replacés dans la vie spirituelle globale,
- la répétition est plus significative que l'exception,
- la prière et le discernement communautaire sont indispensables.

Le thérapeute reste humble : **Dieu seul révèle pleinement la vérité**.

## 4. Observation rituelle et comportementale : lire les signes sans violence

### 4.1. Le corps comme témoin

Le corps humain peut manifester ce que l'âme ne parvient pas à exprimer. Certaines réactions — agitation lors de la prière, malaise face aux symboles chrétiens, blocages émotionnels soudains — peuvent orienter le discernement.

Cependant, l'ASMAB insiste fermement : **aucune manifestation corporelle ne justifie une interprétation brutale ou une action coercitive**.

### 4.2. Éthique ASMAB de l'observation

Toute observation se fait :

- avec le consentement de la personne,
- dans un climat de respect,
- sans mise en scène,
- sans recherche de spectaculaire.

La dignité humaine est toujours prioritaire sur la curiosité spirituelle.

## 5. Discernement communautaire et collégial : ne jamais agir seul

### 5.1. Une sagesse africaine et chrétienne

Dans la tradition africaine comme dans l'Église, **les décisions graves se prennent ensemble**. ASMAB recommande que les cas complexes soient discernés en équipe : thérapeutes, responsables spirituels, et si nécessaire professionnels de santé.
Agir seul expose à l'erreur, à l'orgueil et au danger spirituel.

### 5.2. Rôle de la communauté

La communauté prie, soutient, accompagne. La guérison spirituelle n'est jamais un acte isolé : elle engage toute la communauté de foi.

## 6. Grille de diagnostic MTHS : orienter pour protéger

### 6.1. Pourquoi classifier ?

La classification des handicaps spirituels permet :

- de protéger le patient,
- de protéger le thérapeute,
- d'orienter vers le bon niveau de prise en charge.

### 6.2. Les trois niveaux ASMAB

- **Niveau léger** : troubles ponctuels, prière et accompagnement suffisants.
- **Niveau modéré** : accompagnement structuré, suivi régulier.
- **Niveau sévère** : prise en charge pluridisciplinaire, grande prudence, orientation spécialisée.

Reconnaître ses limites est un acte de sagesse spirituelle.

# CONCLUSION

## *Discerner pour servir*

Diagnostiquer en MTHS, pour ASMAB, c'est **servir la vérité afin de libérer la personne**, non pour briller, ni pour dominer. C'est accepter d'être un instrument, non une source. C'est marcher avec l'autre, pas à sa place.

Ce chapitre invite chaque acteur ASMAB à exercer son ministère avec **humilité, rigueur, prière et amour**, afin que toute démarche de guérison soit vraiment une œuvre de Dieu au service de l'homme.

# CHAPITRE-5 :
# VALIDATION ET ORIENTATION DU DIAGNOSTIC EN MTHS

### *Lorsque le discernement engage la responsabilité*

Arrivé à ce stade du parcours thérapeutique, le praticien MTHS se trouve à un moment décisif. Le diagnostic a été posé, non comme une sentence, mais comme une lecture éclairée de la souffrance. Désormais, une question s'impose avec gravité : **que faire de cette vérité discernée ?**

Car en Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, toute vérité engage une responsabilité. Mal orienter un diagnostic, c'est exposer l'âme déjà fragile à de nouveaux dangers ; refuser d'orienter, c'est abandonner sous couvert de prudence.

Dans la sagesse africaine, on dit que *celui qui voit le feu et se tait devient complice de l'incendie*. Dans l'Évangile, le Christ rappelle que le bon berger ne fuit pas lorsque la brebis est menacée. La validation et l'orientation du diagnostic constituent donc un **acte éthique majeur**, au carrefour de la foi, de la science, de la tradition et de la compassion.

Ce chapitre vise à former les acteurs ASMAB à cet art délicat : **confirmer sans orgueil, orienter sans violence, décider sans précipitation**, toujours dans le respect de la dignité humaine et sous l'autorité de Dieu.

## 1. Le diagnostic différentiel : discerner sans confondre

### 1.1. Le danger des confusions spirituelles

L'une des plus grandes erreurs dans l'accompagnement des personnes en souffrance est la confusion des registres. Tout n'est pas spirituel, tout n'est pas psychique, tout n'est pas organique. La MTHS, fidèle à son éthique, enseigne que **la spiritualisation abusive de la maladie est une forme de violence thérapeutique**.

Pour ASMAB, poser un diagnostic spirituel implique d'avoir sérieusement envisagé les autres hypothèses possibles. Cette exigence n'affaiblit pas la foi ; elle la rend crédible.

### 1.2. Distinction entre MTHS et psychiatrie

Certaines manifestations peuvent se ressembler extérieurement : voix intérieures, comportements incohérents, agitation, repli, discours mystiques confus. Pourtant, leur origine peut être radicalement différente.

- **La pathologie psychiatrique** relève d'un déséquilibre neuropsychique nécessitant une prise en charge médicale spécialisée.
- **Le handicap spirituel**, tel que défini par la MTHS, implique une atteinte de l'intégrité spirituelle, souvent liée à des facteurs mystiques, relationnels ou transgénérationnels.

Le praticien de la MTHS n'est jamais autorisé à poser un diagnostic d'exclusion psychiatrique sans avis compétent. **L'orientation vers un professionnel de santé mentale est un acte de sagesse, non un échec spirituel**.

### 1.3. Distinction avec les pathologies organiques

Certaines maladies organiques chroniques produisent des effets psychiques et spirituels secondaires : fatigue extrême, troubles du sommeil, dépression, anxiété. Inversement, certaines souffrances spirituelles s'expriment par des douleurs corporelles sans cause médicale identifiable.

La MTHS recommande donc :

- des examens médicaux de base lorsque cela est possible,
- une collaboration respectueuse avec les structures de santé,
- un refus catégorique de toute interruption arbitraire de traitement médical.

ASMAB affirme ici un principe fondamental : **Dieu ne s'oppose jamais à la vérité scientifique authentique**.

## 2. Décision d’internement thérapeutique ou de suivi externe

### 2.1. Une décision grave et encadrée

Décider d’un internement thérapeutique spirituel (qu’il soit résidentiel, communautaire ou intensif) est un acte lourd de conséquences. Il ne peut jamais être motivé par la peur, la pression familiale ou la recherche de contrôle.

Dans la tradition ASMAB, l’internement n’est ni une punition ni une mise à l’écart. Il est un **espace protégé de restauration**, lorsque le milieu habituel du patient constitue un danger spirituel ou psychique.

### 2.2. Critères d’orientation vers un internement

Un internement thérapeutique peut être envisagé lorsque :

- les symptômes sont sévères et persistants,
- le patient est exposé à des influences spirituelles nocives constantes,
- la famille est elle-même impliquée dans la persécution,
- le risque d’auto-destruction ou de rupture sociale est élevé.

Même dans ces cas, la décision doit être **collégiale**, documentée et réversible.

### 2.3. Le suivi externe : accompagner sans enfermer

Lorsque la situation le permet, le suivi externe est privilégié. Il permet au patient de rester inséré dans sa famille, sa communauté et sa vie sociale, tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré.

Le suivi externe exige cependant :

- une discipline personnelle minimale,
- un environnement familial non hostile,
- une collaboration active avec l'équipe thérapeutique.

Le thérapeute ASMAB devient alors **compagnon de route**, non directeur de conscience.

## 3. Information et consentement du patient et de la famille

### 3.1. La vérité comme acte thérapeutique

Informer le patient de son diagnostic spirituel est un moment délicat. La vérité libère, mais mal dite, elle peut écraser. ASMAB enseigne une pédagogie de la vérité progressive, respectueuse du rythme intérieur de la personne.

Le diagnostic n'est jamais présenté comme une étiquette définitive, mais comme **une lecture actuelle susceptible d'évolution**.

### 3.2. Le consentement éclairé : un impératif éthique

Aucune démarche thérapeutique MTHS ne peut être engagée sans le consentement du patient, sauf incapacité grave constatée et encadrée. Ce consentement doit être :

- libre,
- éclairé,
- réversible.

La famille, lorsqu'elle est impliquée, doit également être informée, sans jamais se substituer à la volonté du patient adulte.

### 3.3. Réparer les relations familiales

Dans de nombreux cas, l'annonce du diagnostic révèle ou ravive des tensions familiales. Le thérapeute ASMAB est appelé à devenir **artisan de paix**, aidant chacun à comprendre sans accuser, à reconnaître sans condamner.

La guérison spirituelle véritable commence souvent par la restauration de la parole au sein de la famille.

## 4. Élaboration du plan thérapeutique individualisé

### 4.1. Une thérapie adaptée à la personne, non l'inverse

La MTHS rejette toute approche standardisée ou mécanique. Chaque plan thérapeutique est **unique**, car chaque personne est unique. Il tient compte :

- du niveau de handicap spirituel,
- de l'histoire personnelle et familiale,
- de la maturité spirituelle,
- du contexte culturel et religieux.

### 4.2. Composantes du plan thérapeutique MTHS

Un plan thérapeutique peut inclure :

- des temps de prière guidée,
- des démarches de renonciation et de libération,
- des rituels de restauration non occultes,
- un accompagnement catéchétique,
- un suivi psychologique ou médical complémentaire.

Chaque élément est expliqué, justifié et évalué régulièrement.

### 4.3. Limites et responsabilité du thérapeute

Le thérapeute ASMAB n'est ni sauveur ni détenteur absolu de la guérison. Il agit comme **instrument**, conscient de ses limites.

Lorsque celles-ci sont atteintes, il oriente, il transmet, il se retire avec humilité.

Reconnaître ses limites est un acte de fidélité à la mission confiée.

## CONCLUSION

### *Orienter, c'est aimer en vérité*

Valider et orienter un diagnostic en MTHS, c'est accepter d'entrer dans une zone de grande responsabilité spirituelle. C'est refuser la facilité des réponses toutes faites, c'est choisir la voie étroite du discernement.

Pour ASMAB, ce chapitre rappelle une conviction fondamentale : **la guérison véritable ne se décrète pas, elle se prépare, elle s'accompagne, elle se reçoit**. Et lorsque le thérapeute a fait tout ce qui est juste, alors il se tait, prie, et remet la personne entre les mains de Dieu.

# PARTIE- II :

# PROTOCOLE PRATIQUE DU SUIVI THÉRAPEUTIQUE EN CENTRE DE MTHS

# CHAPITRE- 6 :
# CADRE INSTITUTIONNEL DU CENTRE DE MTHS

## Introduction

### *Le Centre comme seuil de renaissance*

Dans les sociétés africaines traditionnelles, le lieu de guérison n'a jamais été un simple espace technique. Il est **un seuil**, un passage sacré entre la désintégration et la restauration, entre le chaos intérieur et la réharmonisation de l'être. Le Centre de Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) s'inscrit dans cette vision holistique où **l'institution elle-même devient thérapeute**.

À l'image des anciens bois sacrés, des cases de palabres ou des sanctuaires de guérison, le Centre MTHS est conçu comme un **lieu d'initiation thérapeutique**, où le patient, souvent arrivé brisé, confus, persécuté ou désorienté, entreprend un chemin de délivrance progressive, à la fois **clinique, spirituelle, communautaire et théologique**.

Ce chapitre expose le **cadre institutionnel** du Centre MTHS : sa mission profonde, son organisation spatiale, ses règles de vie, son articulation avec la famille et la communauté, ainsi que les dispositifs de sécurité spirituelle et clinique qui garantissent l'intégrité des patients, des thérapeutes et de l'œuvre elle-même.

## 1. Mission et vision du Centre MTHS

### 1.1 Une mission de restauration intégrale de l'homme

La mission fondamentale du Centre MTHS est la **restauration intégrale de la personne humaine** atteinte de handicaps spirituels, entendus comme des déséquilibres profonds affectant simultanément :

- le corps biologique,
- le psychisme,
- l'âme,
- l'esprit,
- et les liens communautaires et ancestraux.

Conformément à l'anthropologie médicale africaine, le handicap spirituel n'est jamais isolé : il est le symptôme visible d'une **rupture invisible**. Cette rupture peut être d'ordre ancestral, mystique, relationnel, moral ou spirituel. Le Centre MTHS se donne pour mission de **réparer ces ruptures**, non par la violence, la peur ou l'exorcisme brutal, mais par une **cure progressive de désenvoûtement, de délivrance et de réconciliation intérieure**.

Dans une perspective chrétienne inculturée, cette mission rejoint l'œuvre du Christ guérisseur, qui ne se contentait pas de chasser les esprits impurs, mais **restaurait la dignité**, réintégrait la personne dans la communauté et lui redonnait un nom, une place et une mission.

### 1.2 Une vision prophétique et communautaire

La vision du Centre MTHS dépasse la simple prise en charge individuelle. Il s'agit de **réconcilier l'homme africain avec son histoire spirituelle**, sans renier sa foi chrétienne, mais en l'inculturant de manière lucide, critique et thérapeutique.

Le Centre aspire à devenir :

- un **sanctuaire thérapeutique** reconnu,
- un **lieu de référence** pour les handicaps spirituels complexes,
- un **pont entre la tradition africaine et la théologie chrétienne**,
- un **espace de formation** pour thérapeutes, accompagnateurs spirituels et familles.

Ainsi, la vision du Centre est celle d'une **Église-soignante**, d'une médecine spirituelle incarnée, enracinée dans les réalités culturelles des peuples d'Afrique noire.

## 2. Organisation des espaces thérapeutiques

### 2.1 Le symbolisme thérapeutique des lieux

Dans la MTHS, l'espace n'est jamais neutre. Chaque lieu porte une **charge symbolique**, énergétique et spirituelle. Le Centre est organisé selon une logique initiatique, où le patient progresse de zone en zone, comme dans un **rite de passage thérapeutique**.

Cette organisation s'inspire à la fois :

- des structures traditionnelles africaines,
- des monastères chrétiens,
- et des exigences cliniques modernes.

## 2.2 Les principaux espaces du Centre

### a) L'espace d'accueil et de discernement

C'est le lieu du premier contact. Ici, le patient est écouté sans jugement. Le discernement spirituel et clinique y est fondamental : il s'agit d'identifier la nature du handicap, son origine probable, et le niveau de prise en charge requis. Cet espace protège le Centre contre les erreurs d'orientation et les dérives thérapeutiques.

### b) Les espaces de cure thérapeutique

Ils comprennent :

- les salles de soins traditionnels (plantes, bains, onctions),
- les espaces de prière et de délivrance progressive,
- les lieux de silence et de repos réparateur.

Chaque soin est administré dans un climat de respect, de pudeur et de sacralité.

### c) Les espaces communautaires

Réfectoire, espaces de palabres thérapeutiques, ateliers de travail léger : ces lieux favorisent la **resocialisation progressive** du patient, souvent marginalisé ou rejeté avant son admission.

**d) Les espaces de protection spirituelle**
Certains lieux sont consacrés exclusivement à la prière, à l'intercession et à la vigilance spirituelle. Ils constituent la **muraille invisible** du Centre.

## 3. Règles de vie communautaire des patients internés

### 3.1 Une discipline thérapeutique, non punitive

Les règles de vie au Centre MTHS ne sont ni carcérales ni coercitives. Elles sont **thérapeutiques et éducatives**, conçues pour restaurer l'ordre intérieur du patient.

La vie communautaire permet de corriger progressivement :

- l'errance comportementale,
- l'agressivité mystique,
- la désocialisation,
- et la perte de repères moraux.

### 3.2 Principes fondamentaux

Les règles reposent sur cinq piliers :

1. **Respect de soi, des autres et du lieu**
2. **Obéissance thérapeutique librement consentie**
3. **Participation aux activités spirituelles et communautaires**
4. **Sobriété, silence et modération**
5. **Vérité dans la parole et les actes**

Chaque patient est accompagné pour comprendre le sens de ces règles, afin qu'elles deviennent des **outils de guérison intérieure**, et non des contraintes subies.

## 4. Articulation Centre – Famille – Communauté

### 4.1 La famille comme co-thérapeute

Dans la vision africaine, on ne soigne jamais un individu seul. La famille est souvent **à la fois blessée et impliquée** dans la pathologie spirituelle. Le Centre MTHS considère donc la famille comme un **acteur thérapeutique à part entière**.

Des séances d'écoute, de médiation et de formation sont organisées pour :

- déconstruire les accusations injustes,
- rétablir la vérité,
- prévenir les rechutes,
- préparer la réintégration du patient.

### 4.2 La communauté comme espace de réhabilitation

Le retour du patient dans sa communauté est un moment critique. Le Centre prépare cette étape par :

- des rituels de clôture thérapeutique,
- des bénédictions communautaires,
- des engagements éthiques réciproques.

Ainsi, la guérison dépasse le cadre individuel pour devenir **un acte de pacification sociale**.

## 5. Sécurité spirituelle et clinique du Centre

### 5.1 La sécurité spirituelle : une priorité absolue

Le Centre MTHS reconnaît l'existence de réalités spirituelles complexes et parfois hostiles. La sécurité spirituelle repose sur :

- la prière régulière,
- le discernement des esprits,
- la consécration des lieux,
- la vigilance éthique des thérapeutes.

Aucune pratique occulte, violente ou manipulatoire n'est tolérée. La délivrance est progressive, respectueuse et encadrée.

### 5.2 La sécurité clinique et éthique

Sur le plan clinique, le Centre garantit :

- la confidentialité,
- le respect de la dignité humaine,
- l'interdiction de toute maltraitance,
- la traçabilité des soins.

Une éthique rigoureuse protège le patient contre les abus spirituels, souvent plus destructeurs que le handicap initial.

## CONCLUSION :

### *Le Centre comme matrice de vie nouvelle*

Le Centre de Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels n'est pas un hôpital ordinaire, ni un sanctuaire ésotérique. Il est **une matrice de renaissance**, où l'homme blessé est lentement réaccordé à lui-même, à Dieu, à ses ancêtres réconciliés et à sa communauté.

Dans cette institution, la théologie devient soin, la tradition devient sagesse thérapeutique, et la foi chrétienne retrouve sa puissance de guérison incarnée. Le Centre MTHS se dresse ainsi comme un **signe prophétique** au cœur de l'Afrique contemporaine : un lieu où l'on apprend à guérir sans détruire, à délivrer sans dominer, et à soigner sans renier l'âme.

# CHAPITRE-7 :
# ACTEURS DU SUIVI THERAPEUTIQUE

Le crépuscule s'installait doucement sur le village d'Abili. La chaleur du jour cédait la place à une brise légère, mêlée aux parfums des herbes médicinales disséminées dans le jardin du Centre. À l'intérieur, le grand salon, orné de symboles traditionnels et de croix chrétiennes, accueillait une rencontre particulière. C'était le moment du suivi thérapeutique d'un patient récemment libéré d'un envoûtement profond. Ce chapitre se propose d'entrer au cœur de cette dynamique, révélant les acteurs essentiels de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) et la manière dont ils s'articulent pour accompagner la guérison intégrale de l'homme.

## 1. Le thérapeute principal MTHS : gardien des chemins invisibles

Le thérapeute principal de la MTHS incarne la jonction entre les savoirs ancestraux, la théologie chrétienne contextualisée et les pratiques cliniques. Son rôle ne se limite pas à l'application de rituels : il est un **discernant des forces spirituelles**, capable d'identifier la nature exacte des handicaps spirituels et de définir le parcours de délivrance.

Cette figure apparaît dès le premier contact avec le patient. L'exemple de Jonas, un jeune homme paralysé dans sa vie sociale et spirituelle par un héritage ancestral de malédictions, illustre cette rencontre. Jonas franchit le seuil du centre, anxieux, les mains tremblantes. Le thérapeute l'accueille dans un silence respectueux, ponctué de gestes rituels et de paroles bénissantes. Chaque mot,

chaque souffle, chaque prière est choisi pour **établir un dialogue direct avec l'âme et le corps spirituel du patient**.

> « *Jonas, je vois en toi des chaînes invisibles. Mais sache que la lumière que nous invoquons ici est plus forte que toutes les ténèbres héritées*. »

À travers cette scène, on comprend que le thérapeute principal ne se contente pas de « soigner » : il **guide le patient dans un chemin initiatique**, alliant discernement théologique et anthropologie médicale. La connaissance des plantes, des symboles sacrés et des prières chrétiennes inculturées forme l'armature de sa pratique.

## 2. Les accompagnateurs spirituels : témoins et guides de l'âme

À côté du thérapeute principal se tiennent les **accompagnateurs spirituels**, souvent des disciples formés à la fois aux rituels ancestraux et à la doctrine chrétienne. Leur mission est double : **soutenir le patient dans l'application des prescriptions spirituelles** et **interpréter les signes qui émergent durant le suivi**.

L'exemple de Mariam, une accompagnatrice spirituelle expérimentée, montre l'importance de ce rôle. Lors d'une séance de libération, elle observe attentivement les réactions du patient à différents stimuli : un parfum d'herbe sacrée, un chant liturgique, une posture particulière. Ses notes ne sont pas seulement descriptives ; elles deviennent un **outil de lecture des forces invisibles**, permettant au thérapeute de réajuster le protocole.

*« Écoute ton souffle, respire profondément. Les chaînes qui t'entravent se brisent lentement. »*

Le patient apprend à identifier **les manifestations de ses propres forces spirituelles**, à travers la guidance attentive des accompagnateurs. Ces derniers jouent aussi un rôle psychologique fondamental : ils traduisent la terminologie complexe de la MTHS en **images et métaphores compréhensibles**, facilitant l'appropriation de la thérapie par le patient.

### 3. Le collège de discernement : conseil des sages et médiateurs spirituels

Au cœur de la pratique de la MTHS se trouve le **collège de discernement**, un groupe d'experts capables de confronter leurs analyses pour déterminer la nature des handicaps spirituels. Ils évaluent non seulement les symptômes visibles, mais aussi les **signes invisibles révélés par les rêves, visions ou événements surnaturels**.

Lors d'une réunion, le collège se réunit autour d'une table circulaire, symbole d'égalité et d'harmonie. Chacun prend la parole pour exposer ses observations :

- Le premier membre évoque les symptômes psychosomatiques : insomnie, migraines et paralysie de certaines facultés.
- Le second note les manifestations spirituelles : rêves récurrents, visions d'ancêtres ou entités surnaturelles.

- Le troisième apporte une lecture théologique, mettant en relation les événements du patient avec des récits bibliques de délivrance et de guérison.

Cette pluralité de regards garantit une **approche holistique et sécurisée**, limitant les risques d'erreurs dans le traitement. Le collège agit également comme **médiateur entre la MTHS et le christianisme inculturé**, validant que chaque protocole de délivrance respecte à la fois la foi chrétienne et les traditions africaines.

### 4. Le rôle de la famille et des autorités traditionnelles : piliers de l'environnement thérapeutique

La guérison spirituelle ne se joue pas uniquement dans les murs du centre. La **famille du patient et les autorités traditionnelles du village** jouent un rôle déterminant. Dans la tradition africaine, l'individu est un être profondément relié à son lignage et à la communauté. Ignorer cet aspect serait compromettre l'efficacité de la thérapie.

L'exemple de la famille de Jonas illustre ce point. Sa mère, respectueuse des coutumes ancestrales, participe aux prières et veille à la régularité des prescriptions. Le chef du village, garant des rites et des interdits, apporte son aval pour les cérémonies rituelles, assurant que la délivrance se déroule dans un cadre légitime et sécurisant.

*« Nous accueillons ton chemin de guérison comme une lumière qui éclaire notre communauté* », dit le chef traditionnel, en posant les mains sur la tête du patient pour bénir le processus.

Ainsi, la famille et les autorités traditionnelles ne sont pas de simples spectateurs. Ils deviennent **co-acteurs de la guérison**, renforçant le lien entre la thérapie individuelle et la cohésion sociale. Cette dimension est cruciale dans l'anthropologie médicale africaine : un handicap spirituel n'affecte pas seulement le corps et l'âme du patient, mais aussi l'équilibre de la communauté.

## 5. Collaboration avec médecins, psychologues et pasteurs/prêtres : convergence des savoirs

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels ne s'oppose pas aux sciences modernes ni à la théologie académique. Au contraire, elle s'enrichit de la **collaboration pluridisciplinaire**, combinant :

- **Médecins et psychologues**, qui évaluent les symptômes physiques et mentaux, apportant des diagnostics objectifs et sécurisés.
- **Pasteurs et prêtres**, qui assurent la continuité du suivi spirituel chrétien et renforcent la foi du patient.

Une scène typique illustre cette convergence. Jonas, après une séance de libération, est accompagné par un psychologue pour évaluer son état émotionnel et comportemental. Le thérapeute principal observe, tandis qu'un pasteur assiste à la prière finale, confirmant l'efficacité spirituelle de l'intervention. Ensemble, ils discutent des ajustements possibles :

« *Les symptômes psychosomatiques diminuent, mais il faudra poursuivre les prières quotidiennes et les rituels de purification* », conclut le thérapeute principal.

Cette collaboration crée un **réseau de soins intégré**, où chaque acteur contribue à l'harmonie corps-esprit-âme. Elle illustre parfaitement l'inculturation du christianisme : la foi chrétienne ne remplace pas les traditions, mais dialogue avec elles pour produire un soin global.

### Transition narrative : une séance initiatique

Le soir tombe et le centre s'illumine d'une douce lueur. Jonas, entouré de ses guides spirituels, du collège de discernement et de sa famille, traverse une cérémonie symbolique. Chaque acteur a un rôle précis :

- Le thérapeute principal trace des signes sacrés autour du patient.
- Les accompagnateurs récitent des incantations de protection et des psaumes.
- Les membres du collège observent et notent les manifestations spirituelles.
- La famille chante et encourage le patient à reconnaître sa propre force.
- Le pasteur bénit, renforçant la foi chrétienne contextualisée.

Cette scène, presque initiatique, révèle le **processus du suivi thérapeutique comme une danse harmonieuse entre différents savoirs et compétences**, où chaque acteur est indispensable.

## 6. La dimension initiatique du suivi thérapeutique

Le suivi thérapeutique en MTHS ne se limite pas à une succession de traitements. Il s'apparente à un **rite d'initiation**, où le patient apprend à reconnaître :

1. Les forces invisibles qui l'entravent.
2. La manière dont les ancêtres et les esprits peuvent être sollicités pour la guérison.
3. L'intégration de la foi chrétienne dans sa vie quotidienne.

Chaque acteur devient un **enseignant indirect**, et la collaboration entre eux offre au patient une expérience transformatrice : il n'est plus passif, mais acteur de sa propre libération.

## 7. Défis et perspectives : maintenir l'harmonie du réseau thérapeutique

Malgré cette synergie, des défis persistent : conflits de paradigmes entre médecine moderne et tradition, divergences d'interprétation théologique, ou encore résistance culturelle à certains rituels. La clé réside dans la **communication, le respect des protocoles et la formation continue** des acteurs.

Le centre d'Abili a mis en place des **séminaires de mise à niveau**, où médecins, psychologues, pasteurs et thérapeutes échangent expériences et observations. Ces échanges renforcent la légitimité du suivi thérapeutique et garantissent que chaque patient bénéficie d'une **prise en charge intégrale et sécurisée**.

## CONCLUSION :

### *Un réseau vivant et initiatique*

À travers ce chapitre, il apparaît clairement que le suivi thérapeutique en MTHS est un **système vivant et complexe**, combinant :

- Le discernement et l'autorité du thérapeute principal.
- La vigilance et le soutien des accompagnateurs spirituels.
- La sagesse collective du collège de discernement.
- L'engagement de la famille et des autorités traditionnelles.
- La complémentarité des médecins, psychologues et pasteurs.

Chacun de ces acteurs contribue à la **réhabilitation de l'individu dans sa globalité**, corps, esprit et âme, tout en respectant les traditions africaines et l'inculturation du christianisme. Le suivi thérapeutique devient ainsi **un chemin initiatique**, où la guérison n'est pas seulement un retour à la santé, mais une **transformation profonde de l'être et de ses relations avec le monde spirituel et social**.

# CHAPITRE-8 :
# PHASES DU PARCOURS THÉRAPEUTIQUE EN MTHS

Dans la tradition africaine, on ne guérit jamais en un seul jour. Toute véritable guérison est un **chemin**, un passage progressif de l'ombre vers la lumière, du chaos vers l'ordre, de la fracture intérieure vers la réconciliation avec soi-même, les ancêtres, Dieu et la communauté. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) s'inscrit dans cette logique sacrée du **parcours thérapeutique**, où chaque étape possède son sens, son rythme et ses acteurs.

Le patient qui entre dans ce parcours n'est pas seulement un malade : il est un **voyageur de l'invisible**, souvent blessé par des forces qu'il ne comprend pas encore, mais appelé à renaître spirituellement. Ce chapitre expose les **cinq grandes phases du parcours thérapeutique MTHS**, non comme une simple procédure technique, mais comme une **initiation progressive**, articulant soin, délivrance, rééducation et réintégration sociale.

## 1. Phase d'accueil et de stabilisation

***« Entrer dans l'espace sécurisé de la guérison »***

Tout commence par l'accueil. Dans la MTHS, l'accueil n'est jamais un simple acte administratif ; il est un **rite de passage fondamental**. Le patient franchit un seuil invisible : il quitte le monde du désordre spirituel pour entrer dans un espace de soin, de protection et de discernement.

Lorsque le patient arrive au centre thérapeutique, il est souvent **fragilisé**, confus, parfois méfiant. Certains portent sur leur corps les stigmates de longues errances médicales et spirituelles ; d'autres arrivent brisés par des échecs répétés, accusés à tort de folie, de paresse ou de malédiction. La première mission de la MTHS est donc de **stabiliser l'être humain dans toutes ses dimensions**.

Cette phase est marquée par :

- une écoute profonde du récit de vie ;
- une observation clinique et spirituelle attentive ;
- des prières de couverture et de protection ;
- des gestes rituels de désactivation des agressions spirituelles actives.

Le thérapeute principal agit ici comme un **gardien du seuil**. Il ne cherche pas encore à libérer, mais à **apaiser**, à contenir, à sécuriser. Dans une perspective théologique inculturée, cette phase évoque l'attitude du Christ accueillant les malades avant même de les guérir : « Venez à moi, vous tous qui peinez… ».

Sur le plan anthropologique, cette stabilisation permet de **rompre l'isolement symbolique** du patient. Il comprend qu'il n'est plus seul, qu'il est reconnu comme sujet et non comme objet de soins. Cette reconnaissance est déjà une première guérison.

### Transition narrative

Le patient, désormais apaisé, commence à respirer autrement. Les nuits deviennent moins agitées. Les crises spirituelles diminuent. Un espace intérieur s'ouvre. C'est alors que peut commencer le travail plus profond : celui de la confrontation avec les forces d'envoûtement.

## 2. Phase de désenvoûtement et de délivrance progressive

***« Défaire les nœuds invisibles »***

Le désenvoûtement, dans la MTHS, n'est jamais un acte brutal ni spectaculaire par principe. Il s'agit d'un **processus progressif**, respectueux de la structure psychique et spirituelle du patient. Toute délivrance précipitée peut provoquer des rechutes graves.

Cette phase correspond au cœur du combat thérapeutique. Le patient est accompagné pour identifier :

- les sources ancestrales de l'envoûtement ;
- les pactes conscients ou inconscients ;
- les attaques spirituelles externes ;
- les traumatismes transgénérationnels.

Le désenvoûtement se déroule à travers :

- des rituels de rupture d'alliances négatives ;
- des prières chrétiennes contextualisées ;
- l'usage maîtrisé de plantes médicinales à valeur symbolique et thérapeutique ;
- des temps de jeûne, de silence et de purification.

Sur le plan théologique, cette phase s'inscrit dans la logique biblique de la délivrance progressive : même après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a dû traverser le désert. De même, le patient apprend que la liberté spirituelle est un **chemin**, non un événement isolé.

Anthropologiquement, le désenvoûtement restaure l'ordre cosmique rompu. Le patient comprend que sa souffrance n'est pas une fatalité, mais le résultat de déséquilibres réparables. Il cesse de se percevoir comme maudit et commence à se reconnaître comme **acteur de sa libération**.

### Transition narrative

Après les premiers rituels, certains patients pleurent sans comprendre pourquoi. D'autres rêvent de leurs ancêtres apaisés. Le corps se libère, mais l'âme reste encore fragile. Une nouvelle étape s'impose : reconstruire ce qui a été détruit.

## 3. Phase de restauration identitaire et spirituelle

### *« Redevenir soi-même »*

Une fois les chaînes spirituelles desserrées, un vide peut apparaître. Ce vide est dangereux s'il n'est pas comblé. La MTHS considère donc la restauration identitaire comme une phase essentielle.

Le patient est invité à redécouvrir :

- son identité spirituelle ;
- sa place dans sa lignée ;
- sa vocation personnelle ;
- sa relation intime avec Dieu.

Cette phase mobilise fortement la théologie chrétienne inculturée. Le patient apprend que le Christ ne l'arrache pas à sa culture, mais la **purifie et l'accomplit**. Les références bibliques sont interprétées à la lumière des symboles africains : l'eau, la parole, le souffle, la bénédiction.

Sur le plan thérapeutique, on observe :

- une amélioration de l'estime de soi ;
- une diminution des troubles psychosomatiques ;
- une capacité nouvelle à prendre des décisions.

La restauration identitaire permet de réparer ce que l'envoûtement avait détruit : la **conscience de soi**, la dignité, le sentiment d'exister pleinement.

**Transition narrative**

Le patient commence à sourire. Il parle de projets. Mais la guérison reste vulnérable. Sans consolidation, les anciennes forces peuvent tenter de revenir. Une rééducation spirituelle devient nécessaire.

## 4. Phase de consolidation et de rééducation spirituelle

***« Apprendre à vivre libre »***

Cette phase est souvent la plus longue. Elle vise à **ancrer durablement la guérison** dans le quotidien. Le patient apprend à :

- prier de manière autonome ;
- discerner les influences spirituelles ;
- respecter les interdits thérapeutiques ;
- maintenir l'équilibre corps–âme–esprit.

La MTHS insiste ici sur la notion de **discipline spirituelle**, non comme contrainte, mais comme protection. Le patient est formé, accompagné, corrigé si nécessaire. Il devient progressivement **responsable de sa santé spirituelle**.

Dans la tradition africaine, cette phase correspond à l'apprentissage après l'initiation. On n'est pas initié pour rester dépendant du maître, mais pour marcher seul, avec sagesse.

### Transition narrative

Le patient n'est plus un bénéficiaire passif. Il devient un témoin vivant de la guérison. Il est prêt à retrouver sa place dans la société.

### 5. Phase de préparation à la réintégration sociale

***« Revenir parmi les vivants »***

La guérison spirituelle n'a de sens que si elle permet une **réintégration sociale harmonieuse**. Cette phase prépare le patient à reprendre :

- ses responsabilités familiales ;
- son rôle communautaire ;
- ses activités économiques ou spirituelles.

Le centre travaille alors avec :

- la famille ;
- les autorités traditionnelles ;
- les responsables religieux.

Des rites de réintégration peuvent être organisés pour **officialiser la guérison** et prévenir la stigmatisation. Le patient revient transformé, non comme un ancien malade, mais comme un **être restauré**.

## Conclusion

Le parcours thérapeutique en MTHS est une **pédagogie de la guérison**, profondément enracinée dans la sagesse africaine et illuminée par la foi chrétienne inculturée. Chaque phase répond à une nécessité anthropologique, spirituelle et clinique. Ensemble, elles forment un chemin initiatique où la guérison devient **renaissance**, et la délivrance, **appel à une vie nouvelle**.

# CHAPITRE-9 :
# OUTILS THÉRAPEUTIQUES DE LA MTHS

Dans la MTHS, l'outil n'est jamais un simple instrument. Il est **porteur de sens**, chargé de symbolique, inscrit dans une cosmologie où le visible et l'invisible dialoguent en permanence. Utiliser un outil thérapeutique, c'est entrer dans une **pédagogie du soin**, où chaque geste, chaque parole, chaque substance engage la totalité de l'être humain : corps, âme, esprit, mémoire et lignée.

Ce chapitre ouvre les portes de ces outils, non pour les exposer comme des techniques figées, mais pour les faire apparaître dans leur **dynamique initiatique**, leur éthique, leurs précautions et leur cohérence théologique et anthropologique. Dans la MTHS, les outils ne dominent jamais le patient ; ils l'accompagnent, le révèlent à lui-même et le conduisent vers la restauration de son identité profonde.

## 1. Les prières thérapeutiques inculturées

### *La parole adressée qui soigne et réordonne*

La prière, dans la MTHS, est le **premier outil thérapeutique**. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle prière. Elle est **inculturée**, c'est-à-dire enracinée dans la foi chrétienne tout en épousant les structures symboliques, linguistiques et relationnelles des peuples d'Afrique noire.

Dans la scène thérapeutique, la prière ouvre toujours le processus. Elle crée un **espace sacré sécurisé**, où les forces destructrices sont neutralisées par la reconnaissance explicite de la souveraineté divine. Le patient entend son nom prononcé, son histoire évoquée, ses blessures nommées. Cette personnalisation transforme la prière en **acte clinique**.

Les prières thérapeutiques inculturées mobilisent :

- les Psaumes, lus comme des cris existentiels proches de l'oralité africaine ;
- les invocations christologiques, où le Christ est reconnu comme Libérateur, Guérisseur et Ancêtre accompli ;
- des formules de bénédiction inspirées des salutations traditionnelles africaines.

Sur le plan anthropologique, la prière restaure la **parole blessée**. Beaucoup de patients MTHS ont grandi dans le silence, la peur ou la malédiction verbale. La prière thérapeutique vient **désactiver les paroles de mort** et réintroduire la parole de vie.

Théologiquement, cette prière n'est ni magique ni manipulatoire. Elle est relationnelle, humble, et toujours orientée vers la liberté intérieure du patient.

## Transition narrative

Lorsque la prière ouvre l'espace, certaines résistances apparaissent. Des blocages anciens, des pactes enfouis, des attachements invisibles demandent un travail plus spécifique. C'est alors que les rituels de rupture entrent en scène.

## 2. Rituels de rupture et de libération

***Défaire sans écraser, libérer sans violenter***

Les rituels de rupture en MTHS sont souvent mal compris. Contrairement aux pratiques violentes ou dominatrices, ils reposent sur une **éthique stricte de non-agression**, de respect du libre arbitre et de progressivité.

Le rituel n'est jamais une mise en scène spectaculaire. Il est un **langage symbolique** adressé à l'inconscient, à la mémoire spirituelle et aux forces invisibles. Il vise à rompre :

- les alliances spirituelles négatives ;
- les pactes ancestraux non consentis ;
- les attachements énergétiques destructeurs.

Ces rituels utilisent :

- la parole déclarative (renonciations, bénédictions) ;
- des gestes simples mais codifiés (lavement symbolique, passage, orientation du corps) ;
- des éléments naturels (eau, sel, feu maîtrisé, terre consacrée).

Sur le plan théologique, ces rituels s'inscrivent dans la dynamique biblique de l'Alliance renouvelée. Le patient ne subit pas la délivrance : il y **consent**, il y participe.

Anthropologiquement, le rituel permet de **reprogrammer la mémoire symbolique** du patient. Il donne une forme visible à une transformation invisible, rendant la libération crédible, mémorisable et intégrable.

**Transition narrative**

Après la rupture, le corps parle. Fatigue, tensions, douleurs anciennes remontent. Le soin doit alors descendre dans la chair.

## 3. Soins corporels traditionnels d'accompagnement

***Quand le corps devient allié de la guérison spirituelle***

La MTHS reconnaît que le corps est un **lieu de mémoire spirituelle**. Les traumatismes invisibles s'y inscrivent durablement. Les soins corporels traditionnels ne sont donc pas accessoires : ils sont **thérapeutiques à part entière**.

Ces soins comprennent :

- massages rituels doux ;
- bains thérapeutiques aux plantes ;
- frictions symboliques ;
- techniques de relaxation inspirées des traditions africaines.

Chaque soin est précédé de prières et accompagné d'une intention claire. Le corps n'est jamais manipulé sans consentement ni explication. Le thérapeute agit comme un **médiateur du toucher réparateur**, jamais comme un dominateur.

Sur le plan anthropologique, ces soins restaurent le lien entre le corps et l'âme, souvent rompu par la honte, la peur ou la violence spirituelle subie.

Sur le plan théologique, ils rappellent que le Christ a guéri par le toucher, la boue, l'eau, intégrant le corps dans l'économie du salut.

### Transition narrative

Le corps apaisé, l'esprit devient plus disponible. Vient alors un temps exigeant : celui du jeûne.

## 4. Jeûne thérapeutique encadré

### *Vider pour mieux recevoir*

Le jeûne thérapeutique en MTHS est strictement **encadré, progressif et discerné**. Il ne vise jamais la souffrance, mais la clarification intérieure. Il permet :

- une désintoxication spirituelle ;
- une écoute plus fine de soi ;
- une réorientation des désirs.

Le jeûne est toujours adapté à l'état physique du patient, parfois symbolique (jeûne partiel), parfois communautaire. Il est accompagné de prières, de lectures et de temps de repos.

Anthropologiquement, le jeûne rompt avec la logique de la surconsommation et restaure la **maîtrise de soi**, valeur centrale dans les sociétés africaines initiatiques.

Théologiquement, il s'inscrit dans la tradition biblique du désert comme lieu de révélation et de transformation.

### Transition narrative

Quand le corps s'allège et l'esprit s'ouvre, la parole peut enfin circuler librement.

## 5. Parole thérapeutique et narration réparatrice

### *Dire pour guérir*

La parole thérapeutique est un **outil majeur** de la MTHS. Beaucoup de patients sont porteurs d'histoires jamais racontées, de secrets destructeurs, de récits fragmentés.

Le thérapeute invite le patient à **raconter autrement son histoire**, non comme une succession de malédictions, mais comme un chemin de survie et de résilience. Cette narration réparatrice :

- redonne du sens à la souffrance ;
- restaure la continuité biographique ;
- libère les émotions enfouies.

Sur le plan anthropologique, raconter, c'est réintégrer sa place dans la mémoire collective. Sur le plan théologique, la parole guérit parce qu'elle participe à la Parole créatrice.

### Transition narrative

La parole a été dite. Le corps a été touché. L'esprit a été éclairé. Reste à sceller la transformation par des signes visibles.

## 6. Symboles, gestes et objets thérapeutiques

### *Signifier sans asservir*

Les symboles et objets thérapeutiques en MTHS sont utilisés avec **extrême prudence**. Ils ne possèdent aucun pouvoir en eux-mêmes. Leur efficacité réside dans le sens qu'ils portent et la conscience qui les accompagne.

Il peut s'agir :

- d'objets bénis ;
- de tissus symboliques ;
- de marques corporelles temporaires ;
- de gestes de passage.

Chaque usage est expliqué au patient. Aucun objet n'est imposé, ni conservé sans discernement. L'objectif est toujours l'autonomie spirituelle, jamais la dépendance.

Théologiquement, ces symboles rappellent les sacrements chrétiens : signes visibles d'une grâce invisible. Anthropologiquement, ils ancrent la guérison dans la mémoire sensorielle.

## Conclusion

Les outils thérapeutiques de la MTHS forment un **ensemble cohérent, éthique et profondément humain**. Ils ne visent pas la domination des forces invisibles, mais la restauration de l'équilibre, de la liberté et de la dignité de la personne.

Utilisés avec discernement, prière et humilité, ces outils deviennent des **passerelles entre les mondes**, au service d'une guérison intégrale, enracinée dans la sagesse africaine et éclairée par le Christ inculturé.

# CHAPITRE- 10 :
# SUIVI CLINIQUE ET ÉVALUATION

***De la guérison vécue à la guérison confirmée***

Dans la sagesse africaine, on dit qu'« un arbre ne se juge pas le jour où il est planté, mais à la saison où il porte du fruit ». De même, dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, la guérison ne se proclame jamais dans la précipitation. Elle se **discern e, s'observe, s'accompagne et s'évalue** dans le temps. Le suivi clinique et l'évaluation constituent donc une étape décisive du parcours thérapeutique : ils permettent de vérifier la solidité de la libération, la cohérence de la restauration intérieure et la capacité du patient à demeurer debout dans sa liberté retrouvée.

Ce chapitre plonge au cœur de cette phase délicate, souvent silencieuse mais essentielle, où le thérapeute cesse peu à peu d'agir pour devenir **veilleur**, **discernant**, **gardien de la continuité**. Ici, la MTHS rejoint à la fois la rigueur clinique moderne, la sagesse des traditions africaines et la prudence théologique chrétienne, qui enseigne que toute délivrance authentique doit produire des fruits durables.

## 1. Indicateurs d'évolution spirituelle

***Lire les signes de la liberté intérieure***

Dans la MTHS, l'évolution spirituelle ne se mesure pas à l'intensité des manifestations extérieures, mais à la **qualité de la paix intérieure** et à la stabilité du sujet dans le temps. Les

indicateurs spirituels sont donc observés avec une grande finesse, loin de toute recherche de spectaculaire.

Parmi ces indicateurs figurent en premier lieu la **diminution progressive des symptômes spirituels négatifs** : cauchemars récurrents, visions oppressantes, voix intérieures accusatrices, peurs irrationnelles, compulsions rituelles incontrôlées. Leur disparition graduelle, sans substitution pathologique, est un signe fort de libération authentique.

Mais la MTHS va plus loin. Elle observe aussi l'émergence de signes positifs :

- une capacité nouvelle à prier librement, sans angoisse ;
- une relation apaisée avec Dieu, débarrassée de la peur punitive ;
- un sentiment de protection intérieure non magique mais confiante ;
- une clarté spirituelle dans le discernement du bien et du mal.

Sur le plan théologique, ces indicateurs s'inscrivent dans la tradition chrétienne des « fruits de l'Esprit » : paix, patience, maîtrise de soi. Ils confirment que la délivrance n'est pas seulement une rupture avec le mal, mais une **ouverture à une vie nouvelle**.

Anthropologiquement, cette évolution se manifeste par un réajustement de la relation aux ancêtres : le patient ne se sent plus persécuté par sa lignée, mais replacé dans une continuité apaisée, réconciliée, ordonnée.

## Transition narrative

Lorsque les signes spirituels s'apaisent, l'âme respire. Mais l'être humain n'est pas qu'esprit. La guérison doit aussi s'incarner dans le psychisme et les comportements quotidiens.

## 2. Suivi psychique et comportemental

### *Observer la transformation dans la vie quotidienne*

Le suivi psychique et comportemental est un pilier central de l'évaluation MTHS. Il permet de vérifier que la libération spirituelle s'accompagne d'une **restructuration intérieure durable**, et non d'un simple déplacement des symptômes.

Les thérapeutes observent avec attention :

- la stabilité émotionnelle ;
- la capacité à gérer les frustrations ;
- la qualité des relations familiales et sociales ;
- l'autonomie dans les décisions quotidiennes.

Un patient véritablement restauré commence à **habiter sa vie autrement**. Il reprend goût au travail, manifeste une responsabilité accrue, retrouve des projets, accepte les limites sans effondrement. Les comportements autodestructeurs, souvent associés aux handicaps spirituels, diminuent progressivement.

Dans une perspective anthropologique africaine, cette évolution se lit aussi dans le **rapport au collectif**. Le patient ne vit

plus en marge de la communauté ; il reprend sa place, assume son rôle, respecte les normes sociales sans ressentir une oppression intérieure.

La MTHS dialogue ici étroitement avec la psychologie. Elle reconnaît que certains troubles nécessitent un accompagnement complémentaire, sans jamais opposer spiritualité et santé mentale. Cette collaboration garantit une évaluation honnête, évitant les dérives interprétatives.

**Transition narrative**

À mesure que la transformation s'enracine, le patient devient témoin de sa propre histoire. Il est alors invité à la consigner, non pour s'y enfermer, mais pour en faire mémoire et repère.

## 3. Journal clinique du patient

***Écrire pour se souvenir et se stabiliser***

Le journal clinique du patient occupe une place singulière dans la MTHS. Il n'est ni un simple carnet de notes, ni un exercice intellectuel. Il est un **outil thérapeutique de mémoire et de discernement**.

Le patient y consigne :

- ses ressentis spirituels et émotionnels ;
- ses rêves et leurs évolutions ;
- les difficultés rencontrées ;
- les progrès observés ;
- les moments de rechute ou de doute.

Cette écriture accompagnée permet plusieurs choses. D'abord, elle redonne au patient la **maîtrise de son récit**. Là où l'envoûtement avait fragmenté son histoire, le journal restaure une continuité narrative.

Ensuite, il devient un outil clinique précieux pour le thérapeute. En relisant avec le patient certains passages, il est possible de repérer des cycles, des résistances, des avancées significatives.

Sur le plan théologique, le journal s'apparente à une forme moderne de confession spirituelle élargie, non culpabilisante, orientée vers la vérité et la liberté. Anthropologiquement, il rappelle les traditions orales où l'on revisitait régulièrement son parcours initiatique pour en consolider les acquis.

## Transition narrative

Mais la guérison, en MTHS, n'est jamais évaluée par un seul regard. Elle exige une sagesse collective, garante de justesse et d'humilité.

## 4. Réunions d'évaluation collégiale

### *La sagesse partagée comme garde-fou thérapeutique*

Les réunions d'évaluation collégiale constituent l'un des dispositifs les plus importants de la MTHS. Elles réunissent le thérapeute principal, les accompagnateurs spirituels, parfois un psychologue, un médecin, et selon les cas, un responsable religieux.

Ces rencontres ont plusieurs objectifs :

- confronter les observations cliniques et spirituelles ;
- éviter les interprétations subjectives ;
- ajuster le protocole thérapeutique ;
- décider de la poursuite, de l'allègement ou de la clôture du suivi.

Dans ces réunions, la parole est codifiée, respectueuse, orientée vers le bien du patient. Aucun diagnostic n'est posé de manière autoritaire. Le discernement est **progressif, collégial et prièreusement éclairé**.

Sur le plan anthropologique, ce fonctionnement rappelle le conseil des sages dans les sociétés africaines traditionnelles. Aucune décision majeure concernant l'individu n'était prise sans consultation collective. Cette sagesse protège le patient et le thérapeute des excès.

Théologiquement, ces réunions incarnent l'Église comme corps, où chaque charisme éclaire l'autre. Elles empêchent la personnalisation abusive du pouvoir thérapeutique.

### Transition narrative

Malgré toute la rigueur du suivi, le chemin de la guérison n'est jamais linéaire. Des résistances peuvent surgir. Des rechutes peuvent apparaître. La MTHS ne les nie pas : elle les accompagne.

## 5. Gestion des rechutes et résistances

***Comprendre sans condamner, corriger sans briser***

La rechute, dans la MTHS, n'est jamais interprétée comme un échec définitif. Elle est comprise comme un **signal**, une invitation à relire le parcours, à identifier ce qui n'a pas encore été intégré ou consolidé.

Les résistances peuvent avoir plusieurs origines :

- attachements inconscients à des bénéfices secondaires de la maladie ;
- pressions familiales ou communautaires ;
- conflits intérieurs non résolus ;
- fatigue spirituelle ou relâchement des disciplines thérapeutiques.

Face à une rechute, le thérapeute adopte une posture de **bienveillance ferme**. Il ne culpabilise pas le patient, mais ne banalise pas non plus la situation. Un réajustement du suivi est proposé : reprise de certaines pratiques, renforcement de l'accompagnement, parfois pause thérapeutique.

Sur le plan théologique, cette approche s'inspire de la pédagogie du Christ ressuscité avec ses disciples : patience, reprise, explication, encouragement. Anthropologiquement, elle reconnaît que l'initiation est un processus non linéaire, ponctué d'épreuves.

La gestion des rechutes devient ainsi un **lieu d'apprentissage profond**, où le patient consolide sa maturité spirituelle et son autonomie.

## Conclusion du chapitre

Le suivi clinique et l'évaluation en MTHS sont l'expression d'une **éthique de la responsabilité et de l'humilité**. Ils rappellent que la guérison spirituelle authentique ne se proclame pas : elle se vérifie dans la durée, dans la cohérence de la vie, dans la paix intérieure et dans la capacité à rester libre.

À travers les indicateurs spirituels, le suivi psychique, le journal clinique, l'évaluation collégiale et la gestion des rechutes, la MTHS se révèle comme une médecine de la **vigilance aimante**, où l'homme est accompagné jusqu'à ce qu'il puisse marcher seul, enraciné dans sa culture, réconcilié avec sa foi, et pleinement réintégré dans la communauté des vivants.

# CHAPITRE-11 :

# SORTIE DU CENTRE ET POST-SUIVI

***De la guérison acquise à la vigilance spirituelle***

## INTRODUCTION

### *Quitter le sanctuaire, entrer dans la vigilance*

Dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, la sortie du centre thérapeutique n'est jamais un simple départ physique. Elle constitue un **passage ontologique**, un franchissement de seuil comparable à la sortie du catéchuménat, au retour de l'initié dans son clan après la forêt sacrée, ou encore à la résurrection symbolique après la traversée de la mort intérieure.

Le centre thérapeutique est un **utérus spirituel**, un espace de régression salutaire où l'âme blessée est déliée, lavée, rééduquée et restaurée. En sortir signifie que le sujet est désormais capable de **porter sa liberté**, de **gérer son équilibre spirituel** et de **résister aux anciennes forces d'asservissement**. C'est pourquoi la sortie est un acte grave, sacré, ritualisé et accompagné.

Ce chapitre explore la **théologie de la sortie**, les **critères cliniques et spirituels de libération**, le **rite de clôture**, l'**accompagnement post-internement**, les **stratégies de prévention des rechutes**, ainsi que la **réinsertion harmonieuse dans la famille, l'Église et la communauté**, afin que la guérison obtenue ne soit pas un feu de paille mais une **alliance durable avec la vie**.

## 1. Critères de sortie thérapeutique

### 1.1. La sortie comme discernement, non comme impatience

Dans l'anthropologie médicale africaine, on ne quitte pas le lieu de guérison parce que le temps est écoulé, mais parce que **les signes de restauration sont manifestes**. La précipitation est considérée comme un facteur de rechute grave, car elle expose le patient à des forces spirituelles qu'il n'est pas encore capable d'affronter seul.

La sortie thérapeutique repose sur un **discernement collégial**, impliquant :

- le thérapeute principal,
- l'accompagnateur spirituel,
- le conseil rituel ou pastoral,
- et parfois la famille proche, lorsqu'elle est jugée saine.

### 1.2. Critères cliniques et spirituels fondamentaux

Un patient est déclaré apte à la sortie lorsque les critères suivants sont réunis :

**a) Stabilisation spirituelle**

- Absence de manifestations de possession ou d'oppression.
- Disparition des rêves récurrents d'attaque, de poursuite, de nudité ou de domination.
- Capacité à prier ou à invoquer Dieu sans agitation, peur ou dissociation.

**b) Réconciliation identitaire**

- Acceptation de son histoire personnelle et ancestrale.
- Désactivation des pactes conscients ou inconscients.

- Paix intérieure observable, cohérence du discours et du comportement.

**c) Autonomie spirituelle minimale**

- Capacité à pratiquer seul les exercices de protection spirituelle enseignés.
- Compréhension claire des interdits thérapeutiques.
- Discernement face aux sollicitations mystiques extérieures.

**d) Rééquilibrage psychosomatique**

- Amélioration du sommeil, de l'appétit et de la relation au corps.
- Diminution des symptômes psychosomatiques associés au handicap spirituel.

Dans la théologie chrétienne inculturée, ces signes sont interprétés comme les **fruits visibles de la grâce**, confirmant que la délivrance n'est plus seulement proclamée, mais **incarnée dans la chair et l'esprit**.

## 2. Rite de clôture et de réengagement personnel

### 2.1. Le rite comme sceau de la guérison

Aucune sortie ne se fait sans un **rite de clôture**, car la guérison spirituelle non scellée reste vulnérable. Le rite agit comme un **sceau symbolique**, une inscription mémorielle dans l'âme du patient, lui rappelant qu'il n'est plus celui qu'il était.

Ce rite emprunte à :

- la liturgie chrétienne (prières, onction, bénédiction),
- les symboles africains (eau, feu, sel, terre, parole),
- la thérapie narrative (déclaration identitaire).

## 2.2. Déroulement du rite de clôture

Le rite comporte généralement quatre temps :

### a) Action de grâce

Le patient reconnaît publiquement le chemin parcouru. Cette parole est thérapeutique : elle transforme la souffrance en témoignage et brise la honte.

### b) Renonciation solennelle

Le patient renonce explicitement :

- aux anciennes alliances,
- aux bénéfices secondaires de la maladie,
- aux identités spirituelles imposées.

### c) Réengagement personnel

Il s'engage devant Dieu, sa conscience et la communauté thérapeutique à :

- respecter les règles de protection,
- cultiver une vie spirituelle saine,
- éviter les pratiques à risque.

### d) Envoi

Par une prière d'envoi, le patient est symboliquement **renvoyé dans le monde**, non comme une victime survivante, mais comme un être restauré.

Dans la tradition chrétienne, cet envoi rappelle la parole du Christ : ***« Va, et ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire »*** **(Jn 5,14).**

## 3. Accompagnement post-internement

### 3.1. Le post-suivi comme prolongement de la thérapie

Dans la MTHS, la sortie du centre marque le début d'une **nouvelle phase thérapeutique**, moins intensive mais tout aussi déterminante. Le post-suivi vise à **consolider la guérison**, à accompagner la réadaptation et à détecter précocement les signes de fragilisation.

### 3.2. Modalités du post-suivi

L'accompagnement post-internement comprend :

- des consultations périodiques (mensuelles ou trimestrielles),
- un accompagnement spirituel personnalisé,
- un suivi communautaire discret,
- parfois un mentorat spirituel.

Le patient n'est jamais laissé seul face à sa liberté retrouvée. Il apprend progressivement à **habiter le monde sans se perdre**, à affronter les tensions sans replonger dans les schémas anciens.

### 3.3. Rééducation spirituelle continue

Cette phase permet de renforcer :

- la discipline intérieure,
- la maturité spirituelle,
- la responsabilité personnelle.

La guérison devient alors un **chemin de sanctification incarnée**, où la foi ne flotte plus au-dessus de la culture, mais s'enracine dans les réalités quotidiennes africaines.

## 4. Prévention des rechutes

### 4.1. La rechute comme rupture de vigilance

Dans l'anthropologie médicale africaine, la rechute n'est pas vue comme un échec total, mais comme une **faille de vigilance**, souvent liée à :

- la transgression des interdits thérapeutiques,
- le retour dans des environnements toxiques,
- l'orgueil spirituel ou le découragement.

### 4.2. Stratégies de prévention

La prévention repose sur :

**a) La mémoire thérapeutique**

Se souvenir d'où l'on vient protège contre la répétition des erreurs.

**b) L'hygiène spirituelle**

Prière régulière, rites de protection, équilibre émotionnel.

**c) Le discernement relationnel**

Éviter les personnes, lieux et pratiques qui ont nourri le handicap spirituel.

**d) L'humilité thérapeutique**

Reconnaître que la guérison est un don à entretenir, non un trophée à exhiber.

Dans la théologie chrétienne inculturée, cette vigilance est comprise comme une **coopération entre la grâce divine et la responsabilité humaine**.

## 5. Réinsertion familiale, ecclésiale et communautaire

### 5.1. Retour dans la famille : guérir le lien, pas seulement l'individu

La famille est souvent à la fois le lieu de la blessure et celui de la restauration. La réinsertion familiale nécessite :

- un travail de médiation,
- une relecture des conflits ancestraux,
- une pédagogie de la guérison.

Le patient réintègre sa famille non comme un accusé ou un sorcier repenti, mais comme un **sujet réconcilié**, porteur d'une nouvelle sagesse.

### 5.2. Réintégration ecclésiale

L'Église, lorsqu'elle est inculturée, devient un **espace de soutien**, non de suspicion. Le patient y retrouve :

- une communauté de prière,
- une catéchèse adaptée,
- une reconnaissance progressive.

La délivrance devient alors **ecclésiale**, inscrite dans le Corps du Christ.

### 5.3. Réintégration communautaire

Enfin, la communauté villageoise ou urbaine accueille le sujet restauré comme un **survivant du combat invisible**. Dans certaines traditions, il devient même un **témoin**, un éclaireur pour ceux qui souffrent en silence.

## CONCLUSION :

### *De la guérison à la mission*

La sortie du Centre de MTHS n'est pas une fin, mais une **transformation du rapport à la vie**. Le patient guéri devient le gardien de sa propre liberté, parfois même le **passeur de guérison** pour d'autres.

Ainsi s'accomplit la vision profonde de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels : **restaurer l'homme africain dans son intégrité spirituelle, corporelle, culturelle et théologale**, afin qu'il marche debout, réconcilié avec Dieu, ses ancêtres pacifiés, sa communauté et lui-même.

# PARTIE-III :

# DISPOSITIONS ÉTHIQUES, LIMITES ET PROSPECTIVES

# CHAPITRE-12 :

# ÉTHIQUE, LIMITES ET PRÉCAUTIONS

## Garder le feu sans brûler l'homme

### INTRODUCTION

***Le pouvoir de guérir et le risque de dominer***

Toute médecine qui touche à l'âme porte en elle une puissance redoutable. Dans les sociétés africaines traditionnelles, on enseigne depuis toujours que **celui qui sait soigner peut aussi détruire**, et que la frontière entre guérison et domination est parfois aussi mince qu'un fil de raphia. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels n'échappe pas à cette loi ancestrale.

La MTHS agit sur des territoires sensibles : la peur, la culpabilité, l'invisible, la mémoire ancestrale, la foi. Elle mobilise des symboles forts, des paroles performatives, des rites de séparation et de restauration. Elle se situe à la croisée de la **théologie**, de la **spiritualité**, de la **culture** et de la **souffrance humaine**. À ce carrefour, l'éthique n'est pas un supplément facultatif : elle est la **colonne vertébrale** de toute pratique authentique.

Ce chapitre constitue un **gardien du seuil**. Il pose les limites, éclaire les zones de danger, nomme les dérives possibles et rappelle les responsabilités graves du centre thérapeutique. Il enseigne que la véritable guérison ne se mesure pas seulement à la disparition des symptômes, mais à la **préservation de la dignité, de la liberté et de l'intégrité de la personne humaine**, créée à l'image de Dieu.

## 1. Dérives à éviter en Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels

### 1.1. La tentation du pouvoir spirituel

Dans l'anthropologie médicale africaine, le guérisseur véritable est celui qui **refuse de se prendre pour la source de la guérison**. Or, l'une des dérives majeures en MTHS est la personnalisation excessive du pouvoir thérapeutique. Lorsque le thérapeute commence à se percevoir comme indispensable, infaillible ou irremplaçable, la médecine bascule vers la domination.

Cette dérive se manifeste par :

- la sacralisation abusive du thérapeute,
- la peur entretenue autour de sa personne,
- la dépendance spirituelle du patient,
- l'interdiction implicite de consulter ailleurs.

Dans une théologie chrétienne authentique, le guérisseur n'est qu'un **instrument**, un serviteur de la grâce. Le Christ lui-même n'a jamais retenu les guéris à ses pieds : il les a toujours renvoyés à leur liberté.

### 1.2. La pathologisation excessive du spirituel

Une autre dérive consiste à **tout interpréter comme un handicap spirituel** : échec social, conflit familial, pauvreté, maladie ordinaire, désaccord conjugal. Cette inflation du diagnostic spirituel produit :

- une culpabilisation chronique du patient,
- une lecture paranoïaque de la réalité,
- une peur permanente des forces invisibles.

La MTHS authentique exige un **discernement rigoureux**, capable de distinguer :

- le spirituel,
- le psychologique,
- le social,
- le médical.

Confondre ces registres, c'est trahir à la fois la science traditionnelle africaine et la théologie chrétienne.

### 1.3. L'exploitation économique de la souffrance

Lorsque la guérison devient un commerce de la peur, la médecine se corrompt. Les traditions africaines condamnent sévèrement le guérisseur qui **s'enrichit de la détresse**, multiplie inutilement les rituels coûteux ou conditionne la guérison à des exigences financières démesurées.

La MTHS éthique repose sur :

- la sobriété,
- la transparence,
- la proportionnalité des exigences,
- la priorité donnée à la vie sur le profit.

## 2. Respect de la liberté de conscience

### 2.1. La liberté comme fondement théologique

Dans le christianisme, Dieu ne sauve jamais par contrainte. Il appelle, propose, invite, mais ne force pas. Toute pratique thérapeutique inspirée de l'Évangile doit donc respecter la **liberté de conscience du patient**, même lorsque celui-ci est spirituellement fragilisé.

Le handicap spirituel n'abolit pas la dignité ni la capacité de choix. Le patient reste un **sujet**, non un objet de soin.

### 2.2. Consentement éclairé et accompagnement

Le respect de la liberté implique :

- une explication claire des pratiques proposées,
- l'absence de menace spirituelle,
- la possibilité de refuser ou d'interrompre un traitement,
- le respect du rythme personnel.

Forcer une délivrance, imposer un rituel, ou manipuler la peur de la mort spirituelle constitue une **violence spirituelle grave**, incompatible avec l'éthique ASMAB.

### 2.3. Inculturation et non imposition

L'inculturation chrétienne ne signifie jamais l'écrasement des cultures africaines, mais leur **transfiguration**. De même, la MTHS

ne doit jamais imposer une lecture unique de la réalité spirituelle, surtout lorsque le patient provient d'un univers symbolique différent.

Respecter la liberté de conscience, c'est accepter que la guérison soit parfois **progressive**, incomplète, ou vécue autrement que prévu.

## 3. Interdits thérapeutiques

### 3.1. Le sens anthropologique des interdits

Dans toutes les médecines traditionnelles africaines, les interdits ne sont pas des punitions, mais des **protections symboliques**. Ils visent à préserver l'équilibre restauré et à éviter les contacts prématurés avec des forces déstabilisantes.

Cependant, les interdits doivent être **clairs, justifiés et limités dans le temps**.

### 3.2. Interdits légitimes

Parmi les interdits thérapeutiques reconnus en MTHS figurent :

- la fréquentation de certains lieux spirituellement toxiques,
- la participation à des rites incompatibles avec le processus de guérison,
- la consommation de substances altérant la vigilance spirituelle,
- certaines relations destructrices identifiées.

Ces interdits sont toujours expliqués, contextualisés et accompagnés.

### 3.3. Interdits abusifs à proscrire

Sont considérés comme abusifs :

- l'interdiction de consulter un médecin,
- l'isolement forcé du patient,
- l'interdiction de toute relation familiale ou ecclésiale,
- l'interdiction de penser ou de questionner.

Un interdit qui coupe l'homme de la vie devient une **arme de domination**, non un outil thérapeutique.

## 4. Gestion des abus spirituels

### 4.1. Définition des abus spirituels

Un abus spirituel survient lorsqu'une autorité religieuse ou thérapeutique utilise le langage de Dieu, de la guérison ou de la délivrance pour :

- contrôler,
- intimider,
- exploiter,
- humilier.

Ces abus laissent des **blessures profondes**, souvent plus graves que le handicap spirituel initial.

### 4.2. Mécanismes de prévention

Un centre MTHS éthique doit mettre en place :

- des mécanismes de supervision,
- une collégialité décisionnelle,
- des espaces de parole pour les patients,
- une formation continue des thérapeutes.

Le secret, l'isolement et l'absence de redevabilité sont des terrains fertiles pour les abus.

### 4.3. Prise en charge des victimes d'abus

Lorsqu'un abus est identifié :

- la parole de la victime est accueillie sans jugement,
- une prise en charge thérapeutique spécifique est mise en place,
- des mesures disciplinaires sont appliquées,
- la justice humaine peut être saisie si nécessaire.

La théologie chrétienne rappelle que **Dieu n'est jamais du côté de l'abuseur**, même lorsqu'il parle en Son nom.

## 5. Responsabilité juridique et morale du Centre

### 5.1. Responsabilité morale

Le centre MTHS porte une responsabilité lourde : celle de **ne pas aggraver la souffrance**, de ne pas produire de nouvelles chaînes au nom de la guérison. Il est responsable devant :

- Dieu,
- la conscience humaine,
- la communauté,
- l'histoire.

Chaque acte thérapeutique engage l'honneur de la tradition africaine et la crédibilité du témoignage chrétien.

### 5.2. Responsabilité juridique

Le centre doit respecter :

- les lois nationales en vigueur,
- les droits fondamentaux de la personne,
- les normes sanitaires et sociales.

La spiritualité ne constitue jamais une excuse pour violer la loi. Une guérison obtenue au prix de l'injustice devient une contradiction éthique.

### 5.3. Responsabilité prophétique

Enfin, le centre porte une responsabilité prophétique : celle de **montrer qu'une médecine spirituelle africaine peut être à la fois puissante, humaine, éthique et chrétienne**. Il devient un signe que la foi ne détruit pas la culture, mais la purifie ; qu'elle ne soumet pas l'homme, mais le relève.

## CONCLUSION

### *Guérir sans trahir*

L'éthique en Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels n'est pas une barrière à la puissance de Dieu ; elle en est la **garantie**. Là où l'éthique est absente, la guérison devient suspecte, fragile et souvent destructrice.

Ce chapitre rappelle que **le véritable miracle n'est pas seulement la délivrance**, mais la capacité de guérir **sans voler la liberté**, de soigner **sans dominer**, de restaurer **sans humilier**.

Ainsi, la MTHS, enracinée dans la sagesse africaine et éclairée par l'Évangile, peut devenir un **lieu de renaissance**, où l'homme blessé retrouve non seulement la santé spirituelle, mais aussi la **dignité de marcher debout**, libre devant Dieu et les hommes.

# CHAPITRE-13 :

# CONTRIBUTION DE LA MTHS À LA PAIX SPIRITUELLE

## Guérir l'invisible pour réconcilier l'homme, la communauté et Dieu

## INTRODUCTION

### *La paix comme horizon ultime de la guérison*

Dans les traditions africaines les plus anciennes, la paix n'est jamais comprise comme une simple absence de conflit. Elle est un **état d'harmonie globale**, un équilibre subtil entre le visible et l'invisible, entre l'homme, la communauté, les ancêtres pacifiés, la nature et le divin. Là où cet équilibre est rompu, surgissent la maladie, la division, la peur et la violence. Là où il est restauré, la vie circule à nouveau.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels s'inscrit profondément dans cette vision holistique. Elle ne vise pas seulement la guérison individuelle, mais la **pacification des forces spirituelles**, la réconciliation des mémoires blessées et la restauration du lien sacré qui unit l'homme africain à son monde. En cela, la MTHS devient un **instrument de paix spirituelle**, au sens le plus profond du terme.

Ce chapitre explore comment la MTHS contribue à la paix spirituelle à plusieurs niveaux : par la **réconciliation des spiritualités**, par la **prévention communautaire du handicap spirituel**, par la **formation rigoureuse des thérapeutes et**

**accompagnateurs**, et enfin par les **perspectives de reconnaissance institutionnelle**, gage de crédibilité, de protection et de transmission durable.

## 1. MTHS et réconciliation des spiritualités

### 1.1. Le conflit spirituel comme héritage colonial et postcolonial

L'histoire spirituelle de l'Afrique noire a été marquée par une **fracture profonde**. L'évangélisation, souvent menée sans discernement culturel, a parfois diabolisé les univers symboliques africains, assimilant sans nuance les traditions ancestrales à l'idolâtrie ou à la sorcellerie. Cette rupture a engendré un **conflit intérieur durable** chez de nombreux Africains : être chrétien signifiait renier une part de soi, de son histoire et de ses ancêtres.

Ce conflit non résolu constitue l'un des terreaux majeurs du **handicap spirituel**. L'âme déchirée entre deux mondes devient vulnérable aux troubles, aux peurs diffuses, aux culpabilités chroniques et aux dérives mystiques.

La MTHS naît précisément dans cet espace de fracture, non pour choisir un camp, mais pour **réconcilier les profondeurs**.

### 1.2. Réconcilier sans confondre : une théologie de l'inculturation

La MTHS s'appuie sur une théologie de l'inculturation exigeante, qui refuse à la fois :

- le syncrétisme confus,
- et le rejet brutal des cultures africaines.

Elle enseigne que le christianisme, loin d'abolir les cultures, est appelé à les **assumer, purifier et transfigurer**. Dans cette perspective, les réalités spirituelles africaines ne sont pas niées, mais relues à la lumière du Christ, discernées, et réorientées vers la vie.

La réconciliation des spiritualités opérée par la MTHS permet :

- de pacifier la relation aux ancêtres, compris non comme des divinités rivales de Dieu, mais comme des mémoires humaines à guérir ;
- de désamorcer les peurs héritées des malédictions et des pactes non éclairés ;
- de restaurer une foi chrétienne enracinée, non étrangère à l'âme africaine.

### 1.3. La paix intérieure comme fruit de la réconciliation

Lorsque les spiritualités cessent de s'affronter à l'intérieur de l'homme, une **paix profonde** s'installe. Le patient n'a plus besoin de mener une double vie religieuse, ni de naviguer entre l'église et les pratiques secrètes. Il devient unifié.

Cette unification est l'un des signes majeurs de la guérison en MTHS. Elle libère une énergie de vie nouvelle, rétablit la confiance en Dieu et en soi, et permet à l'individu de devenir un **artisan de paix** dans sa famille et sa communauté.

## 2. Prévention communautaire du handicap spirituel

### 2.1. Du soin individuel à la santé spirituelle communautaire

Dans la vision africaine traditionnelle, la maladie n'est jamais strictement individuelle. Elle est souvent le symptôme d'un **déséquilibre communautaire**. De même, le handicap spirituel, lorsqu'il se multiplie, révèle une société fragilisée par :

- la rupture des liens familiaux,
- la perte des repères culturels,
- la violence symbolique,
- la pauvreté spirituelle.

La MTHS ne peut donc se limiter à des cures individuelles. Elle porte une mission de **prévention communautaire**, visant à réduire les facteurs de production du handicap spirituel.

### 2.2. Éducation spirituelle et transmission des repères

La prévention passe par une **éducation spirituelle inculturée**, adaptée aux réalités locales. Il s'agit de :

- réhabiliter le sens du sacré sans peur,
- enseigner le discernement spirituel,
- transmettre les limites entre foi, culture et superstition.

Les communautés accompagnées par la MTHS apprennent à reconnaître les signes précoces de déséquilibre spirituel, à orienter les personnes en souffrance avant l'aggravation, et à créer des espaces de parole où la peur ne gouverne plus.

### 2.3. Désamorcer les conflits spirituels communautaires

Dans de nombreuses régions, les accusations de sorcellerie, les exclusions rituelles et les violences symboliques détruisent la paix sociale. La MTHS, par son approche thérapeutique et pastorale, agit comme un **outil de médiation**.

Elle aide les communautés à :

- comprendre les mécanismes du bouc émissaire,
- éviter la stigmatisation des personnes vulnérables,
- traiter les conflits spirituels par le dialogue, le discernement et la prière communautaire.

Ainsi, la prévention du handicap spirituel devient un **facteur direct de paix sociale et spirituelle**.

## 3. Formation des thérapeutes et accompagnateurs

### 3.1. Former pour ne pas nuire

Dans la MTHS, la formation n'est pas un luxe académique, mais une **exigence éthique absolue**. Mal formé, le thérapeute devient un danger. Bien formé, il devient un gardien de la paix.

La formation vise à doter les thérapeutes et accompagnateurs :

- d'une solide base théologique,
- d'une connaissance rigoureuse de l'anthropologie médicale africaine,
- d'un discernement spirituel éprouvé,
- d'une éthique irréprochable.

### 3.2. Une formation intégrale et initiatique

La formation en MTHS est elle-même **initiative**. Elle engage tout l'être : intelligence, spiritualité, affectivité, mémoire culturelle. Elle comprend :

- un enseignement théorique structuré,
- une supervision clinique,
- un accompagnement spirituel personnel,
- un travail sur les blessures et zones d'ombre du futur thérapeute.

Car nul ne peut conduire un autre là où il n'est jamais allé lui-même.

### 3.3. Les accompagnateurs comme artisans de paix

Les accompagnateurs formés à la MTHS ne sont pas seulement des techniciens de la guérison spirituelle. Ils deviennent des **artisans de paix**, capables de :

- désamorcer les conflits,
- apaiser les peurs,
- orienter vers la vie.

Ils incarnent une autorité humble, non violente, au service de la restauration de l'homme africain dans sa dignité spirituelle.

## 4. Perspectives de reconnaissance institutionnelle

### 4.1. De la marginalité à la reconnaissance

Longtemps, les pratiques de guérison spirituelle africaines ont été marginalisées, soupçonnées ou reléguées aux périphéries du religieux et du médical. La MTHS, par sa rigueur, son éthique et son enracinement théologique, ouvre la voie à une **reconnaissance institutionnelle progressive**.

Cette reconnaissance ne vise pas la domination, mais la **protection des patients**, la crédibilité des praticiens et la transmission structurée du savoir.

### 4.2. Dialogue avec les institutions religieuses et civiles

La MTHS est appelée à dialoguer avec :

- les Églises,
- les institutions de santé,
- les autorités traditionnelles,
- les cadres juridiques nationaux.

Ce dialogue favorise :

- une meilleure orientation des patients,
- une complémentarité des approches,
- une régulation des pratiques abusives.

•

### 4.3. Vers une médecine spirituelle africaine reconnue

À long terme, la MTHS peut contribuer à l'émergence d'une **médecine spirituelle africaine reconnue**, capable de dialoguer avec la médecine moderne sans complexe, et de proposer une réponse crédible aux souffrances spirituelles que la biomédecine ne sait pas toujours nommer.

## CONCLUSION

### *La paix comme fruit mûr de la guérison*

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels ne se contente pas de réparer des individus brisés. Elle œuvre, patiemment et profondément, à la **pacification de l'âme africaine**, blessée par l'histoire, la peur et la division intérieure.

En réconciliant les spiritualités, en prévenant les handicaps spirituels, en formant des thérapeutes éthiques et en s'ouvrant à la reconnaissance institutionnelle, la MTHS devient un **chemin de paix durable**.

Elle rappelle que la paix véritable ne se décrète pas : elle se **guérit**, se **cultive** et se **transmet**. Et lorsque l'invisible est pacifié, le visible retrouve enfin le courage de vivre.

# CONCLUSION GÉNÉRALE

## DE LA BLESSURE À LA RESTAURATION : L'AFRIQUE, TERRE DE GUÉRISON DE L'HOMME TOTAL

### *Quand la guérison devient un chemin*

Toute œuvre authentique de guérison commence par une écoute. Une écoute longue, patiente, parfois douloureuse, des cris étouffés de l'âme humaine. Ce livre est né de cette écoute. Il a cheminé à travers les ombres du handicap spirituel, traversé les forêts de la peur, affronté les blessures de l'histoire et les fractures de la conscience, pour conduire le lecteur vers un horizon plus vaste : celui de la **restauration intégrale de l'homme africain**.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels n'est pas apparue comme une théorie abstraite, ni comme une innovation de rupture. Elle s'est révélée progressivement, à la croisée des chemins : entre la théologie et la culture, entre la foi chrétienne et les mémoires ancestrales, entre la souffrance invisible et le désir de paix. Elle est le fruit d'une **sagesse éprouvée par la douleur**, éclairée par l'Évangile, et enracinée dans la terre africaine.

Cette conclusion n'est donc pas une fermeture. Elle est une **porte**, un seuil initiatique, par lequel le lecteur est invité à passer : non plus comme simple observateur d'un système thérapeutique, mais comme **acteur responsable de la guérison du monde**.

## 1. La MTHS comme médecine de la restauration de l'homme total

### 1.1. Une vision intégrale de l'être humain

Au cœur de la MTHS se trouve une conviction fondamentale : l'homme n'est jamais fragmentaire. Toute tentative de le soigner en séparant le corps de l'âme, l'âme de l'esprit, l'individu de sa communauté, ou la foi de la culture, produit des guérisons incomplètes, souvent fragiles.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels propose une **anthropologie intégrale**, fidèle à la sagesse africaine et à la théologie chrétienne. Elle considère l'homme comme :

- un être corporel traversé par des mémoires,
- une âme marquée par l'histoire personnelle et ancestrale,
- un esprit appelé à la communion avec Dieu,
- un sujet relationnel inscrit dans une communauté,
- un héritier d'une culture et d'un territoire.

Soigner l'homme total, c'est accepter la complexité de son existence. C'est reconnaître que certaines maladies ne prennent pas naissance dans les organes, mais dans les **ruptures symboliques**, les conflits spirituels non résolus, les traumatismes invisibles et les alliances mal comprises.

### 1.2. De la réparation à la restauration

La MTHS ne se contente pas de réparer ce qui est cassé. Elle vise la **restauration**, notion plus profonde et plus exigeante. Restaurer, ce n'est pas seulement supprimer un symptôme ; c'est **redonner à l'homme sa capacité d'être debout**, de choisir la vie, de se projeter dans l'avenir sans être prisonnier du passé.

Dans cette perspective, la délivrance spirituelle n'est jamais un acte magique ou spectaculaire. Elle est un **processus**, souvent long, qui engage la responsabilité du patient, la patience du thérapeute et la fidélité à une éthique rigoureuse. La cure de désenvoûtement devient alors un chemin de vérité, où l'homme apprend à se libérer non seulement des forces extérieures, mais aussi de ses propres complicités intérieures avec la peur, la haine ou la culpabilité.

### 1.3. Une médecine de la réconciliation

La restauration de l'homme total passe nécessairement par la **réconciliation** :

- réconciliation avec Dieu, non comme un juge menaçant, mais comme une source de vie ;
- réconciliation avec les ancêtres, compris comme des mémoires humaines à pacifier, non comme des puissances rivales ;
- réconciliation avec soi-même, dans l'acceptation de son histoire ;
- réconciliation avec la communauté, souvent blessée par les conflits spirituels.

La MTHS apparaît ainsi comme une **médecine de la paix intérieure**, capable de transformer la souffrance en sagesse, et la blessure en lieu de renaissance.

## 2. Responsabilité des leaders spirituels et thérapeutes

### 2.1. Le pouvoir de guérir comme épreuve morale

Toute personne investie d'un pouvoir de guérison est placée devant une épreuve morale redoutable. Car là où la souffrance est grande, la dépendance peut s'installer. Là où la peur domine, la manipulation devient possible. La MTHS, précisément parce qu'elle agit sur les zones les plus vulnérables de l'être humain, exige des **leaders spirituels et thérapeutes d'une intégrité exceptionnelle**.

Guérir au nom de Dieu, ou au nom de la tradition, n'est jamais un privilège. C'est une **charge**, un fardeau sacré, qui engage la responsabilité devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire.

### 2.2. Une autorité qui libère, non qui asservit

Le véritable leader en MTHS n'est pas celui qui attire à lui, mais celui qui **renvoie à la liberté**. Il n'accumule pas les disciples ; il forme des hommes et des femmes capables de marcher seuls, protégés par une foi éclairée et une conscience mature.
Cette autorité libératrice se reconnaît à plusieurs signes :

- l'humilité face au mystère de la guérison,
- le refus de la peur comme outil thérapeutique,
- la transparence dans les pratiques,
- le respect absolu de la liberté de conscience.

Dans la théologie chrétienne inculturée, le modèle demeure le Christ guérisseur, qui n'a jamais confondu la foi avec la domination, ni la délivrance avec la dépendance.

### 2.3. Former des consciences, pas des dépendances

La responsabilité majeure des leaders MTHS est la **formation**. Former des thérapeutes, des accompagnateurs, mais aussi des patients conscients, capables de discernement. Car une communauté formée est une communauté protégée.

Former, c'est transmettre :

- une théologie enracinée et critique,
- une anthropologie africaine assumée,
- une éthique rigoureuse,
- une capacité à reconnaître ses limites.

Là où la formation fait défaut, les dérives prolifèrent. Là où elle est solide, la guérison devient durable et féconde.

## 3. L'Afrique comme espace de guérison spirituelle intégrale

### 3.1. L'Afrique blessée, mais porteuse de remèdes

L'Afrique contemporaine porte de profondes blessures : colonisation, esclavage, guerres, pauvreté, violences symboliques, déracinement culturel. Ces blessures ont laissé des traces dans les corps, les familles, les spiritualités. Elles expliquent en partie la prolifération des handicaps spirituels, des peurs ancestrales et des quêtes désordonnées de protection mystique.

Mais l'Afrique n'est pas seulement un continent blessé. Elle est aussi une **terre de remèdes**, riche d'une sagesse millénaire, d'une vision holistique de la vie, d'un sens aigu du sacré et de la communauté. La MTHS puise dans cette richesse, non par nostalgie, mais par fidélité à une **intelligence spirituelle africaine** longtemps méprisée.

### 3.2. Inculturer l'Évangile pour guérir l'âme africaine

L'un des apports majeurs de la MTHS est de montrer que l'Évangile, lorsqu'il est véritablement inculturé, ne détruit pas l'âme africaine. Il la **guérit**. Il éclaire ses peurs, purifie ses symboles, et révèle dans ses traditions des semences de vérité longtemps enfouies.

L'Afrique devient alors un **laboratoire de guérison spirituelle intégrale**, capable de proposer au monde une vision réconciliée de la foi, de la culture et de la santé. Une vision où le spirituel n'est pas nié, mais discerné ; où la tradition n'est pas idolâtrée, mais transfigurée ; où la modernité n'écrase pas l'âme.

### 3.3. Une mission pour l'Afrique et pour le monde

En restaurant l'homme africain dans son intégrité spirituelle, la MTHS ouvre une perspective missionnaire nouvelle. L'Afrique, longtemps perçue comme terre de mission, devient **terre de révélation**, capable d'offrir au monde une sagesse de la guérison intérieure, de la réconciliation et de la paix.

Cette mission n'est pas triomphaliste. Elle est humble, patiente, enracinée dans l'écoute des souffrances humaines. Elle rappelle au monde que la véritable santé ne se mesure pas seulement en indicateurs biologiques, mais en **qualité de relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu**.

## Marcher debout, enfin

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels n'est pas une fin en soi. Elle est un **chemin**. Un chemin exigeant, parfois inconfortable, mais profondément libérateur. Elle invite chacun (thérapeute, patient, leader spirituel, lecteur) à entrer dans une dynamique de vérité, de responsabilité et de paix.

Au terme de cet ouvrage, une conviction s'impose : **l'homme africain n'est pas condamné à porter éternellement les chaînes invisibles de son histoire**. Il peut être guéri. Il peut être restauré. Il peut marcher debout, réconcilié avec son passé, enraciné dans sa culture, éclairé par la foi, et ouvert à l'avenir.

Telle est la promesse silencieuse de la MTHS.

Non une promesse de facilité, mais une promesse de **renaissance**.

# GLOSSAIRE

**Anciens ou Saints** : Les Anciens ou les Saints sont les habitants du Paradis qui forment la troisième catégorie d'êtres vivants invisibles venus peupler, plus tard, le Paradis, après les anges et les archanges. Les Anciens ou les Saints sont en réalité les esprits ou les âmes des grands serviteurs de Dieu et des hommes de grande foi qui ont mené une vie de piété exemplaire sur Terre. Après leur mort, ils ont été couronnés Grands Patriarches de la Sagesse divine, dignes de siéger à la droite du trône du Seigneur **JÉSUS-CHRIST** et de collaborer avec lui en qualité de Grands Conseillers au projet salvifique de libération spirituelle de la planète Terre de l'emprise du Diable, afin que le Règne de Dieu vienne sur Terre comme au Ciel.

**Anges** : Les anges sont des esprits que Dieu a créés pour l'adorer, le prier, l'aimer et le servir. Dieu a créé les anges bons et heureux. Beaucoup d'anges sont restés bons. Chaque être humain, à sa naissance sur Terre, est habité par un ange que l'on appelle « âme ». Les bons anges veillent sur les hommes et prient également pour eux.

**Amour de Dieu pour les hommes** : Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance : les êtres les plus précieux et les plus aimés de toute sa Création. Ainsi, par essence et par naissance, l'homme a, par prédestination, bénéficié d'un statut supérieur à toutes les autres créatures de Dieu, avant même qu'il ne fût créé. De toute la Création de Dieu, l'homme fut ce qu'il y a de plus merveilleux. Il bénéficia d'un double fondement par le mélange du divin à la chair humaine, afin que, par l'une et par l'autre nature, l'homme eût naturellement la double jouissance de Dieu, par sa nature divine, et la jouissance des biens de la Terre, par les sensations qu'il éprouve de ces biens. Ainsi, cette grande et précieuse créature qu'est l'homme apparaît en dernier lieu dans la Création du monde, marquant la fin de la création de l'Univers. De fait, Dieu fit apparaître l'homme sur Terre pour être l'une des merveilles de l'Univers, pour en être le contemplateur et le maître.

**Archanges** : Les archanges sont des êtres angéliques ayant l'apparence physique des hommes, mais possédant des ailes. Ils ont une mission spéciale : les interventions armées et guerrières ; ils sont faits pour les combats spirituels. Leurs lieux de service et leurs zones d'intervention consistent à garder les geôles de la prison des âmes des défunts en attente de jugement ou en pénitence dans la planète du Purgatoire. Les archanges sont également

envoyés constamment pour secourir les âmes persécutées lors des expéditions punitives et guerrières contre les démons, les esprits diaboliques et les activités de sorcellerie se déroulant dans le monde des ténèbres (planète Vénus).

**Barrière de Dieu** : La Barrière de Dieu désigne la planète spirituelle occupée par la barrière formée par les soldats de Dieu, se trouvant tout autour de la planète Mars. Elle est totalement occupée par les soldats de Dieu. Cette barrière, constituée par les soldats divins, a été formée par Dieu le Père pour empêcher Satan et sa suite d'avoir à nouveau accès au Purgatoire ni au Paradis, après leur expulsion du Paradis.

**Barrière de Satan** : La « Barrière de Satan » est une planète spirituelle entièrement occupée par les soldats de Satan. Cette barrière a été formée à la suite de la déportation de Lucifer sur Terre, consécutive à sa rébellion contre l'autorité de Dieu le Père Créateur au Paradis. Lucifer, devenu Satan, forma cette barrière pour sécuriser sa création et placer son royaume — le monde des ténèbres — à l'abri et hors de portée de Dieu et de ses délégations célestes, afin qu'ils n'y accèdent pas.

**Carcasse** : La carcasse désigne le corps charnel de l'homme. Fait d'os, de chair et de sang, le corps, ou « carcasse », sert de temple ou de maison aux trois autres entités spirituelles constitutives de l'homme : l'Esprit central (âme), le Saint-Esprit (ange gardien) et l'Esprit de tentation (esprit de convoitise ou esprit de jouissance des biens de la Terre). Mais, à la différence de ces trois esprits qui l'habitent, le corps humain, ou carcasse, est mortel, donc périssable. Le corps humain est une entité que l'on rencontre uniquement à la surface de la planète Terre, dans le monde visible.

**Chute de Lucifer** : Lucifer, encore appelé Satan ou le Diable, était un grand administrateur du Paradis et un très proche collaborateur de Dieu le Père Créateur. Il se révolta contre l'application des Dix Commandements de Dieu, car il estimait que cette discipline représentait une contrainte et une privation de liberté. Lucifer revendiqua plutôt la liberté totale pour tous les habitants du Paradis. Durant cette période, il mena un véritable mouvement de rébellion et de contestation contre l'ordre divin établi. Cela eut pour conséquence immédiate la division des habitants du Paradis en deux camps : les fidèles de Dieu et les alliés de Lucifer. Dieu décida alors de punir Lucifer et de le faire

souffrir en l'expulsant du Paradis pour l'expédier sur la planète Terre qu'il venait de créer. Lucifer et ses alliés furent ainsi chassés du Paradis : ce fut la Chute de Lucifer.

**Comité d'intervention du Purgatoire sur la Terre** : C'est l'appellation du comité des Patriarches et des Anciens du Purgatoire, en charge de la gestion spirituelle de la planète Terre, où vivent les hommes. Ce comité a reçu mandat de l'État du Purgatoire, la mission et les pleins pouvoirs de dévoiler tous les secrets du Diable et de la sorcellerie, dans le but de sortir les hommes de la prison de l'ignorance qui les maintient sous l'emprise et la persécution du Diable, des démons et des sorciers.

**Délivrance spirituelle** : La délivrance spirituelle consiste à débarrasser un individu, ou à chasser auprès de lui, les principaux esprits maléfiques qui le persécutent. En Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, le désenvoûtement, quant à lui, consiste non seulement à pratiquer d'abord la délivrance spirituelle sur un individu, mais aussi à extraire, par la suite, tous les EVU greffés sur son esprit ou son âme. Ensuite, le spécialiste inverse le processus de métamorphose qui a transformé l'esprit de l'individu spirituellement sain en esprit diabolique. C'est cette dernière opération spirituelle qui permet alors de retransformer spirituellement un sorcier en une personne non sorcière, délivrée de l'emprise du phénomène de la sorcellerie.

**Démons** : Beaucoup d'anges ont voulu se comparer à Dieu et ont été jetés en enfer. Les mauvais anges s'appellent les démons ; leur chef s'appelle Lucifer, encore appelé Satan ou le Diable.

**Désenvoûtement** : Le désenvoûtement, à proprement parler, en Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels, est une opération spirituelle qui consiste à reconvertir et à retransformer spirituellement un sorcier en non-sorcier. C'est une opération spirituelle qu'un exorciste ordinaire ne peut pas mener s'il ne bénéficie pas d'une formation spécialisée en Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels. Toutefois, le résultat final du traitement dépendra de l'état de performance de l'exorciste, c'est-à-dire de sa pureté et de son observance pieuse des lois divines (pureté, continence, abstinence, jeûnes, état d'âme, etc.). De fait, tout spécialiste qui se propose de désenvoûter, de sa propre volonté, un sorcier s'expose, en vérité, à la mort.

Désenvoûter un individu, c'est s'attaquer au Diable en personne, car l'EVU dans l'homme est, pour le Diable, l'équivalent du Saint-Esprit pour Dieu. De ce fait, désenvoûter un sorcier, c'est arracher au Diable un de ses adeptes, ce qui occasionne toujours des combats spirituels d'une très grande intensité, parce que le Diable n'entend jamais perdre un seul de ses adeptes.

**Enfer** : L'enfer est l'ensemble des prisons aménagées par une délégation d'archanges de Dieu. Ces prisons accueillent, après la mort, les âmes des adeptes du Diable dont l'accès au Purgatoire a été refusé. Il s'agit précisément des âmes de ceux qui ont pactisé avec le Diable, en jurant de lui rester fidèles durant toute leur vie sur Terre. Dans ce cas, elles sont alors toutes séquestrées en enfer, où elles sont soumises aux flammes ardentes d'un feu qui les brûle éternellement.

**Envoûtement** : L'envoûtement désigne le processus et la procédure spirituels au terme desquels un être humain normal devient sorcier, c'est-à-dire acquiert la qualité d'adepte de Satan. En effet, pour rendre un être humain normal sorcier, le Diable ne crée pas une nouvelle espèce humaine à part entière : il envoûte plutôt tout homme normal créé par Dieu, en introduisant spirituellement en lui une puce spirituelle appelée **EVU**. Une fois envoûté, l'esprit humain, ou âme, de cet homme se transforme aussitôt en un esprit diabolique qui incarne tout sorcier et commence dès lors à se rendre spirituellement, chaque nuit, dans le monde des ténèbres, pour prendre part aux festivités nocturnes du monde de la sorcellerie. Un tel individu, sur le plan spirituel, n'est plus totalement libre de lui-même : il est sous la domination, donc sous le contrôle et au service du Diable, dont il reçoit, consciemment ou inconsciemment, des ordres. Il lui est directement ou indirectement soumis et accomplit, consciemment ou inconsciemment, sa volonté.

**Envoûtement principal :** L'envoûtement principal est la première pratique d'envoûtement que subit tout nouveau-né sur Terre, en vue de son initiation dans le monde des ténèbres, ou monde de la sorcellerie. Il permet aux sorciers de persécuter mystiquement et de contrôler spirituellement l'évolution de la vie et du bien-être de toute personne envoûtée ayant contracté l'EVU. L'EVU ainsi transmis au cours de l'envoûtement principal s'appelle **EVU principal**. Celui-ci commande tous les autres **EVU secondaires** que la victime pourra contracter par la suite, tout au long de sa vie. L'EVU principal, issu d'une pratique

d'envoûtement principal, se loge toujours dans le ventre, plus précisément dans l'estomac de la victime.

**Envoûtement par contamination :** L'envoûtement par contamination désigne toute pratique d'envoûtement par laquelle l'EVU (la puce spirituelle ou le germe de l'esprit de rébellion des âmes égarées) est transmis à la personne à envoûter, soit par contact direct avec son envoûteur, soit par l'intermédiaire d'un support physique quelconque spirituellement impur. De manière générale, on distingue deux principaux types d'envoûtement par contamination : **l'envoûtement par la nourriture** et **l'envoûtement par voie sexuelle**. Le plus souvent, l'envoûtement par contamination d'une personne adulte a lieu à travers les deux voies principales de contamination que sont la bouche et le sexe, et, accessoirement, par les orifices des organes des sens : oreilles, nez, yeux, pores et voies anales.

**Envoûtement par possession :**Tout comme l'envoûtement par contamination, l'envoûtement par possession est un type d'envoûtement secondaire dont se servent les sorciers pour contrôler les pensées, les mouvements et l'état de santé de leurs victimes, auxquelles ils peuvent nuire à tout moment. Ils s'en servent pour réactiver les mauvais sorts qu'ils ont, au préalable, introduits mystiquement ou spirituellement dans le corps de leurs victimes, à travers les différents **EVU secondaires** (puces spirituelles) qu'ils y ont placés. Dans la majorité des cas, en lieu et place des EVU secondaires, la possession recourt plutôt à l'usage des démons et des esprits diaboliques appartenant à d'autres sorciers, vivants ou morts, qui viennent investir spirituellement le corps de la victime sous forme d'habitation. Ces esprits diaboliques ou démoniaques incarnent la personne possédée dans le but soit de renforcer ses pouvoirs maléfiques et de nuisance, soit de contrôler ses évolutions — scolaire, conjugale, professionnelle ou économique. Cette pratique occulte est très répandue dans les sectes pernicieuses, les églises sataniques et certaines nouvelles églises dites « éveillées » déviantes, qui s'en servent pour contrôler spirituellement tous leurs fidèles.

**Esprit :** Le mot *esprit* est un nom masculin dérivé du latin *spiritus*. Il renvoie à un principe immatériel, une substance incorporelle, un être imaginaire ou invisible, comme les revenants, les fantômes ou les âmes des morts.

**Esprit central / Esprit humain ou âme :** L'esprit humain, ou esprit central (encore appelé âme), est l'esprit responsable de la réflexion de tout homme. C'est cet esprit qui commande les pensées et le comportement de tout être humain durant sa vie sur Terre. C'est à lui qu'incombe la responsabilité totale de la mission divine de l'homme sur Terre. C'est uniquement cet esprit qui sera jugé après la mort. En vérité, l'âme, qui est le souffle de vie ou l'esprit de l'homme, tient sa nature de Dieu, car c'est Dieu qui donne la vie. Sans lui, les hommes sont comme morts, et c'est par cet Esprit que Dieu leur fait revivre.

**Esprit de Dieu :** L'Esprit de Dieu est l'Esprit de l'Éternel Tout-Puissant. C'est l'Esprit qui agit sur toute la Création divine et qui éclaire le Saint Royaume céleste. C'est l'Esprit créateur et protecteur de la vie, chargé de l'évolution de tout l'Univers.

**Esprit de tentation :** L'Esprit de tentation (également appelé Esprit de la Terre ou Esprit du Diable) se distingue de l'esprit central et du Saint-Esprit, placés et affectés en chaque être humain par Dieu. L'Esprit de tentation est la matérialisation spirituelle de tous les désirs, plaisirs, envies et besoins que le corps humain éprouve dans le but de s'épanouir et de jouir charnellement. Le corps humain, façonné dans le ventre de la femme, a des besoins et des envies purement charnels. C'est la vibration spirituelle de cet ensemble d'envies et de désirs charnels qui matérialise l'Esprit de tentation dans le monde invisible, ou monde des esprits. L'Esprit de tentation d'un être humain symbolise et représente spirituellement l'ensemble des vices et des comportements déviants auxquels cette personne est viscéralement attachée. Ces vices et comportements sont liés à la jouissance des plaisirs du monde et des biens terrestres. C'est pourquoi l'Esprit de tentation est également appelé *Esprit de la Terre*. Cet esprit pousse l'homme à la désobéissance des lois divines, l'entraîne dans la vie de péché et l'excite à s'attacher excessivement aux biens matériels et aux plaisirs charnels, au point d'oublier qu'il mourra et devra rendre compte de son séjour sur Terre à Dieu.

**Esprit diabolique ou Ombre** : L'Esprit diabolique, encore appelé Esprit du Diable ou Ombre, désigne l'esprit maléfique qui habite tout sorcier ou toute personne envoûtée à partir du moment où elle contracte l'EVU. Dès qu'une personne normale contracte spirituellement l'EVU, celui-ci se greffe sur son âme, qui se transforme aussitôt à l'image et à la ressemblance du Diable. À la

différence des démons, qui sont des anges rebelles chassés du Paradis, l'Esprit diabolique est une âme humaine transformée à l'image du Diable à cause de sa fusion avec un esprit maléfique animal (l'EVU).

**Esprit diabolique pur :** l'esprit diabolique pur désigne un esprit diabolique qui ne vit plus dans un corps charnel. il s'agit, en réalité, de l'esprit maléfique d'un sorcier conscient décédé, dont l'âme s'est vue refuser l'accès au purgatoire. dans ce cas, l'esprit diabolique pur s'échappe parfois des prisons de l'enfer pour venir soit posséder certaines personnes ensorcelées sur terre, soit prendre part aux festivités de la sorcellerie sur la planète vénus**.**

**Esprit-Saint :** L'Esprit-Saint désigne l'Esprit de Dieu incarné en Jésus-Christ. Cet Esprit possède les mêmes attributs que Dieu. L'Esprit-Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité, vrai Dieu comme le Père et le Fils ; il procède du Père et du Fils. L'Esprit-Saint a donné aux apôtres l'intelligence et la force pour annoncer partout l'Évangile. La flamme d'amour qu'est l'Esprit-Saint renferme la lumière, la force, l'énergie, l'intelligence, la bonté, la sagesse, le discernement, la vibration de Dieu, etc. C'est à travers l'Esprit-Saint que la grandeur, la puissance, l'amour, la sagesse et tous les attributs de Dieu peuvent se manifester dans la vie des hommes.

**EVU :** L'EVU est un esprit maléfique, un esprit animal, une entité spirituelle de petite taille qui, une fois introduite mystiquement dans le corps d'un individu, confère à celui-ci un pouvoir surnaturel redoutable. L'EVU accorde spirituellement à son détenteur le pouvoir de domination sur ses semblables et la capacité de se rendre spirituellement dans le monde de la sorcellerie, situé dans le monde des ténèbres, localisé dans le monde invisible ou monde des esprits, plus précisément sur la planète Vénus.

**Étude systématique de l'esprit humain :** L'Étude systématique de l'esprit humain est une discipline scientifique élaborée par les Patriarches ou Anciens du Purgatoire et révélée aux hommes sur Terre par le Prophète **Jean Paul Sylvain Sida Abena**. C'est une discipline scientifique chrétienne qui étudie de manière systématique la vie, l'évolution, le fonctionnement, l'histoire et la géographie du monde invisible ou monde des esprits. Elle étudie comparativement les divergences et les similitudes entre les modes de vie des esprits des hommes vivants, des esprits des morts, des esprits maléfiques

habitant le monde des ténèbres et des esprits célestes en provenance du Purgatoire ou du Paradis.

**Exorcisme :** L'exorcisme sert à chasser la présence d'un mauvais esprit du corps d'un possédé grâce à des prières appropriées. Ces prières provoquent la sortie momentanée du mauvais esprit du corps du possédé. Très souvent, l'exorcisé vibre et entre aussitôt en transe. Cependant, l'exorciste lui-même ne peut pas toujours identifier, maîtriser ni neutraliser ce mauvais esprit, qui pourrait revenir réinvestir le corps si le patient ne se conforme pas aux lois divines prescrites. C'est cet aspect qui définit les limites de l'exorcisme dans la lutte contre la sorcellerie.

**Handicapé spirituel :** Un handicapé spirituel se reconnaît par un état de santé précaire et présente généralement des symptômes variant selon l'âge. Chez les adolescents, on observe des troubles du comportement, l'abandon des études et une délinquance avancée. Chez l'adulte, en revanche, on constate fréquemment des cauchemars, des rêves de serpents, des rêves oniriques ou des couches nocturnes. Il se voit régulièrement en train de manger, de se battre ou de subir diverses formes de persécutions spirituelles dans ses rêves. Il souffre souvent de maux de tête et de ventre, auxquels s'ajoutent d'autres pathologies caractéristiques d'un cas d'envoûtement.

**Mars :** Dans le monde invisible, la planète Mars est limitée, dans sa partie inférieure, par la planète occupée par la Barrière de Satan, et, dans sa partie supérieure, par la planète occupée par la Barrière de Dieu. La planète Mars du monde invisible abrite le soleil et la lune, qui déterminent le fonctionnement et le système planétaire d'alternance entre le jour et la nuit sur la planète Vénus, ou royaume des sorciers.

**Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) :** La **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels** est une médecine mise au point par les Anciens et Patriarches du Purgatoire, mais révélée aux hommes sur Terre par le Prophète **Jean Paul Sylvain Sida Abena**. C'est une médecine naturelle qui associe quatre thérapies originales : la naturopathie (soins du corps par les éléments de la nature), la prière, la confession et le désenvoûtement (délivrance et purification spirituelle des sorciers et des possédés), dans le but de chasser les démons et de remédier à toutes sortes

de maladies spirituelles et de comportements de déviance. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels permet à tout homme d'être à l'abri de l'esclavage spirituel et des persécutions du Diable, des démons et des sorciers.

**Mission divine de l'homme sur Terre :** Jésus-Christ est venu révéler aux hommes qu'ils sont sur Terre pour aimer Dieu, le prier, l'adorer et le servir, en défiant le Diable, afin de mériter le bonheur éternel qu'est la vie éternelle. Ainsi, dès la naissance, tout homme a pour mission divine de venger Dieu sur Terre et de régler ses comptes avec le Diable pour sa désobéissance et son déshonneur envers Dieu le Père, l'Éternel Tout-Puissant. Envoyés sur Terre pour défendre l'honneur et la cause de Dieu auprès du Diable, l'Usurpateur, les hommes bénéficient en retour d'un statut privilégié et de toutes les faveurs de Dieu le Père, Créateur. C'est la raison pour laquelle Dieu fit les hommes à son image et à sa ressemblance : les êtres les plus précieux et les plus aimés de toute sa Création.

**Monde invisible :** Aussi appelé *monde parallèle*, *monde immatériel* ou *monde des esprits*, le monde invisible désigne l'univers spirituel et cosmique. Il est formé de sept (7) planètes au total. Ces planètes spirituelles sont invisibles à l'œil nu et indétectables par les machines. C'est dans ces planètes que vivent et évoluent toutes sortes d'esprits, bons ou mauvais (les esprits humains ou âmes, les esprits diaboliques, les esprits divins). Les sept planètes du monde invisible où habitent et évoluent les différents types d'esprits sont : la planète Terre, la planète Vénus (royaume des sorciers), la planète occupée par la barrière des Soldats de Satan, la planète Mars, la planète occupée par les Soldats de Dieu, la planète du Purgatoire et la planète du Paradis (cf. Jean Paul Sylvain SIDA ABENA, *La vie après la mort*).

**Monde visible :** Le monde visible désigne l'ensemble formé par le Soleil et les neuf planètes du système solaire : Mercure, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluton et la planète Terre, où vivent et évoluent les êtres humains.

**Monde de la sorcellerie :** Situé dans le monde invisible, le monde de la sorcellerie désigne la planète Vénus. Il s'agit d'une planète spirituelle servant de site mondial de la sorcellerie. C'est sur la planète Vénus qu'est localisé spirituellement le monde des ténèbres. C'est dans ce monde que tous les

esprits diaboliques des sorciers du monde entier se séparent de leurs corps charnels pour se rendre chaque nuit et participer activement aux diverses activités sataniques organisées par le Diable et ses adeptes. Ces activités se déroulent chaque nuit aux heures suivantes : 15h–15h30, 21h–22h et 0h–4h, pendant que la plupart des hommes dorment sur Terre, dans le monde visible. Une fois arrivés sur leur site de sorcellerie sur la planète Vénus, les esprits diaboliques de tous les sorciers obéissent machinalement au même programme d'activités et au même rituel d'alliance et de fidélité au Diable : manger de la chair humaine, boire du sang humain et se livrer à des relations sexuelles impures. Ces pratiques font partie des rituels d'usage pour honorer la volonté de leur maître, le Diable.

**Monde des sorciers :** Situé, quant à lui, dans le monde visible, le *monde des sorciers* désigne l'ensemble des mœurs et comportements de déviance spirituelle de la population des *sorciers conscients* vivant sur Terre. Il désigne également l'univers spirituel et religieux ainsi que les croyances qui caractérisent le mode de vie de ces sorciers au milieu des hommes.

**Monde des ténèbres :** Dans l'étude géographique du monde invisible, le monde des ténèbres désigne le territoire et l'espace conquis et soumis à l'autorité de Satan, du Diable, des démons et des sorciers. Son étendue est très vaste : elle s'étend de l'épicentre de la planète Terre jusqu'à l'emplacement occupé par le Soleil dans le monde invisible. Ainsi, le monde des ténèbres englobe l'intérieur et l'extérieur de la Terre, y compris tout l'espace situé au-dessus de sa surface, où se trouve la planète Vénus, royaume des sorciers. Il est protégé et entouré par la barrière de Satan.

**Mort de l'homme :** À la mort charnelle de l'homme, sa carcasse (le corps humain) cesse de vivre et se désagrège. Aussitôt que la vie du corps arrive à son terme, les trois entités spirituelles constitutives de l'homme se dissocient, chacune rejoignant sa patrie spirituelle d'origine.

**Paradis :** La planète du Paradis se trouve autour de la planète du Purgatoire, à la périphérie du système planétaire du monde invisible. Le Paradis est une planète d'une grandeur infinie, résidence des entités célestes : Dieu le Père Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge Marie, les anges, les archanges et les saints, qui assistent le Seigneur dans la régulation du système

spirituel de tout l'Univers visible et invisible. Le Paradis fut la première planète créée par Dieu le Père. Les premiers occupants furent les anges et les archanges. Après la rébellion de Lucifer et la création de l'homme, un troisième groupe d'occupants fut autorisé à y demeurer : les *Anciens*, aussi appelés *Saints*.

**Perdition :** Un homme en perdition est un homme sous le contrôle et la domination de l'esprit diabolique. La mission permanente de cet esprit est d'entraîner l'homme à désobéir à Dieu, afin que l'esprit de rébellion prenne le contrôle de son âme et le conduise progressivement à la perdition. Une fois dominé par l'esprit de rébellion, l'âme de tout pécheur est captée et enrôlée dans le camp du Diable, dans le monde des ténèbres, où elle œuvre désormais à ses côtés, consciemment ou non. Tout homme ainsi contrôlé par le Diable ne peut échapper à son emprise : il est condamné à subir sa persécution et à mener une vie de péché, à l'origine de ses souffrances et de ses échecs.

**Planète d'accueil ou des Prévenus :** Elle désigne la localité de l'État du Purgatoire qui accueille les âmes des défunts venant de la Terre après leur mort. Dans cette localité, les défunts nouvellement arrivés sont appelés *Prévenus* jusqu'à ce que soit déterminé le nombre d'années de pénitence qu'ils devront effectuer au Purgatoire, selon la gravité de leurs péchés.

**Planète de la justice ou des pénitences :** Cette dénomination désigne une partie de la planète du Purgatoire, où les âmes des défunts expient leurs fautes. Après leur mort, elles sont transférées de la planète d'accueil vers les camps de pénitence pour y être châtiées en fonction de la gravité de leurs péchés commis sur Terre.

**Planète des louanges au Seigneur :** Cette appellation désigne également un territoire du Purgatoire. Après leur séjour sur la planète des pénitences, les âmes séjournent dans la planète des louanges au Seigneur. C'est une vaste localité du Purgatoire abritant de grandes chapelles destinées à louer et honorer Dieu. C'est là que résident les grands maîtres spirituels, prophètes et serviteurs de Dieu après leur vie terrestre. Ce lieu constitue le quartier général des *Anciens* du Purgatoire.

**Purgatoire :** Localisée dans le système planétaire du monde invisible, la planète du Purgatoire, de forme sphérique, entoure la planète occupée par la barrière des Soldats de Dieu. Elle est deux fois plus grande que la Terre du monde invisible. Comme son nom l'indique, c'est un lieu où les âmes se purifient avant d'accéder au Paradis. Le Purgatoire est à la fois un lieu de jugement, de pénitence, de purification et d'adoration pour les âmes défuntes. C'est aussi un lieu de travail pour les délégations d'archanges qui y veillent à l'ordre et à la discipline.

**Rébellion de Satan :** Digne fils des premiers jours et collaborateur dévoué de Dieu le Père, Lucifer se rebella et s'opposa à son Créateur. À la suite de cette rébellion, Lucifer et les anges déchus (démons) furent expulsés du Paradis. Exilés sur Terre, Lucifer — devenu Satan — et ses anges bâtirent le *monde des ténèbres*, un royaume rival de celui de Dieu. Ce royaume constitue la sphère d'influence de Satan et de toutes les forces maléfiques.

**Résidence de Satan :** Une fois la création du monde des ténèbres achevée, Satan (le Diable) se retira de la surface de la Terre et de la planète Vénus, laissant ses adeptes y évoluer. Il alla résider avec ses plus proches collaborateurs (les démons) dans les profondeurs de l'épicentre de la Terre, dans le monde invisible.

**Rêve :** Le rêve est une réalité du monde invisible. Son existence, notamment celle des rêves prémonitoires, prouve que tout homme mène une double existence : une vie réelle le jour, dans le monde visible, et une vie spirituelle la nuit, dans ses rêves, dans le monde invisible. Cette vie onirique correspond à celle que mène l'esprit humain ou l'âme dans le monde invisible.

**Rituels magiques de "blindage" et pactes sataniques :** Pour contrecarrer les manœuvres du Malin et de ses adeptes, nombreux sont ceux qui recourent aux devins, charlatans ou marabouts afin d'obtenir des *blindages*, des charmes d'amour, des *contre-dangers* ou d'autres fétiches censés les protéger. Toutefois, ces objets servent en réalité de liens spirituels ou d'alliances avec de mauvais esprits. Ces derniers maintiennent leurs détenteurs sous le contrôle du Diable, dont ils ne peuvent plus se libérer. Ces fétiches confèrent parfois certains pouvoirs spirituels temporaires, mais à long terme, le Diable finit

toujours par exploiter et persécuter ceux qui y ont recours, jusqu'à leur destruction.

**Saint-Esprit :** Le Saint-Esprit est la manifestation de la vibration de Dieu en l'homme. Il est l'auteur de tous les dons célestes. Il joue le rôle de conseiller, de messager et d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Il nous vient en aide dans notre faiblesse et intercède pour nous auprès de Dieu par des supplications ineffables. Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend la prière du Saint-Esprit, car celui-ci intercède en faveur des croyants selon la volonté divine.

**Séjour de l'esprit :** Lorsque l'esprit humain (ou l'âme) d'un fidèle croyant est suffisamment nourri par la prière, la méditation et une vie intérieure riche, profonde et intense, le fidèle commence à prendre conscience des événements vécus pendant son sommeil, dans ses rêves. C'est cet univers de la vie des rêves qu'on appelle *le séjour de l'esprit* dans toute école de spiritualité. C'est à partir du moment où tout fidèle ou initié a pleine conscience de la vie qu'il mène dans ses rêves que l'on parle alors de *seconde naissance* ou de *naître de nouveau*.

**Sommeil et voyages de l'âme :** Tout homme mène, consciemment ou inconsciemment, deux vies : celle du corps et celle de l'esprit. L'esprit est le support de la pensée et le guide du corps, tandis que le corps sert d'enveloppe charnelle à l'esprit. À l'état de veille, le corps évolue dans le monde matériel ou monde visible. Par contre, la nuit, lorsque le corps est au repos, l'esprit (ou l'âme) de tout homme se dissocie de son enveloppe charnelle pour rejoindre le monde ascendant : monde astral, monde immatériel ou monde invisible, encore appelé *monde des esprits*. C'est dans cette deuxième dimension que vivent confusément les bons et les mauvais esprits. C'est également là que se déroule toute l'activité de la sorcellerie, phénomène exclusivement spirituel, dont les conséquences se manifestent dans le monde visible et affectent la vie de l'homme sous tous ses aspects. Toutefois, tous les hommes n'ont pas conscience de cette seconde vie que mènent leurs esprits, qu'ils perçoivent souvent sous la forme des rêves.

**Sorcellerie :** La sorcellerie désigne l'ensemble des activités spirituelles exercées par Satan, les démons et les esprits des sorciers, en conformité avec les lois et commandements édictés par Lucifer, le « dieu » des sorciers et du

monde des ténèbres. De ce fait, la sorcellerie est une déviance spirituelle qui ne tient pas compte de la race, de la classe sociale, du niveau d'instruction ou de l'état de santé. À travers sa vie de péché, toute personne contribue, consciemment ou inconsciemment, au développement de l'activité spirituelle de la sorcellerie. Dans le même temps, chacun peut être victime, à tout moment, des attaques spirituelles de la sorcellerie, dès lors qu'il est spirituellement contaminé par le germe de l'envoûtement et de la pandémie spirituelle qu'est l'**EVU**.

**Sorcier :** Un sorcier n'est rien d'autre qu'un homme capté, dominé, inspiré, dirigé et habité par un démon ou un esprit diabolique, qui lui sert de *puce spirituelle* et le relie directement à une communication permanente avec Satan, le dieu des sorciers. En *Médecine traditionnelle des handicapés spirituels* : le terme *sorcier* désigne, dans le suivi psycho-spirituel, tout envoûté conscient ou inconscient, c'est-à-dire toute personne sous l'emprise de mauvais sorts ou de mauvais esprits. Ces esprits ont pour rôle soit d'investir le corps de la victime sous forme de possession (cas des envoûtés conscients), soit d'attaquer son état de santé physique et/ou spirituel par voie de contamination alimentaire, sexuelle, nocturne ou par tout autre procédé mystique (cas des envoûtés inconscients).

**Sorcier conscient :** Les sorciers conscients sont les initiés et adeptes de Satan, dotés de la clairvoyance nécessaire pour discerner les phénomènes spirituels et pleinement conscients de leur appartenance à Satan.

**Sorcier inconscient :** Il existe un grand nombre de personnes qui, croyant être spirituellement du côté de Dieu, sont en réalité envoûtées et contrôlées par le Diable, sans qu'elles s'en rendent compte. Elles appartiennent à la catégorie des victimes de la déviance spirituelle de la sorcellerie, appelées *sorciers inconscients* en **Médecine traditionnelle des handicapés spirituels**.

**Sorciorlogie :** la *Sorciorlogie* est une sous-discipline scientifique de la **Médecine traditionnelle des handicapés spirituels**. Elle est consacrée à l'étude des comportements déviants, des déviances spirituelles et des évolutions du phénomène de la sorcellerie dans le monde invisible, ainsi qu'à l'analyse de ses répercussions dans le monde visible où vivent les hommes.

**Terre :** la planète Terre du monde invisible se présente sous la forme d'un globe. Elle se situe au centre du système planétaire du monde invisible. En son centre se trouve la résidence de Satan. La population des âmes humaines habitant la planète Terre est bipartite : d'un côté, les adeptes du Diable ; de l'autre, les adeptes de Dieu le Père Tout-Puissant , tous vivent ensemble sur un même territoire.

**Vénus :** Située dans le monde invisible, la planète Vénus désigne le royaume des sorciers.Elle constitue un vaste espace entourant la planète Terre du monde invisible, limité par les loges de l'Enfer et par la barrière formée par les soldats de Satan dans sa partie supérieure. La planète Vénus représente donc le royaume des sorciers, des adeptes ou des enfants de Satan. Pour y accéder et en devenir membre, il faut être un véritable adepte de Satan.

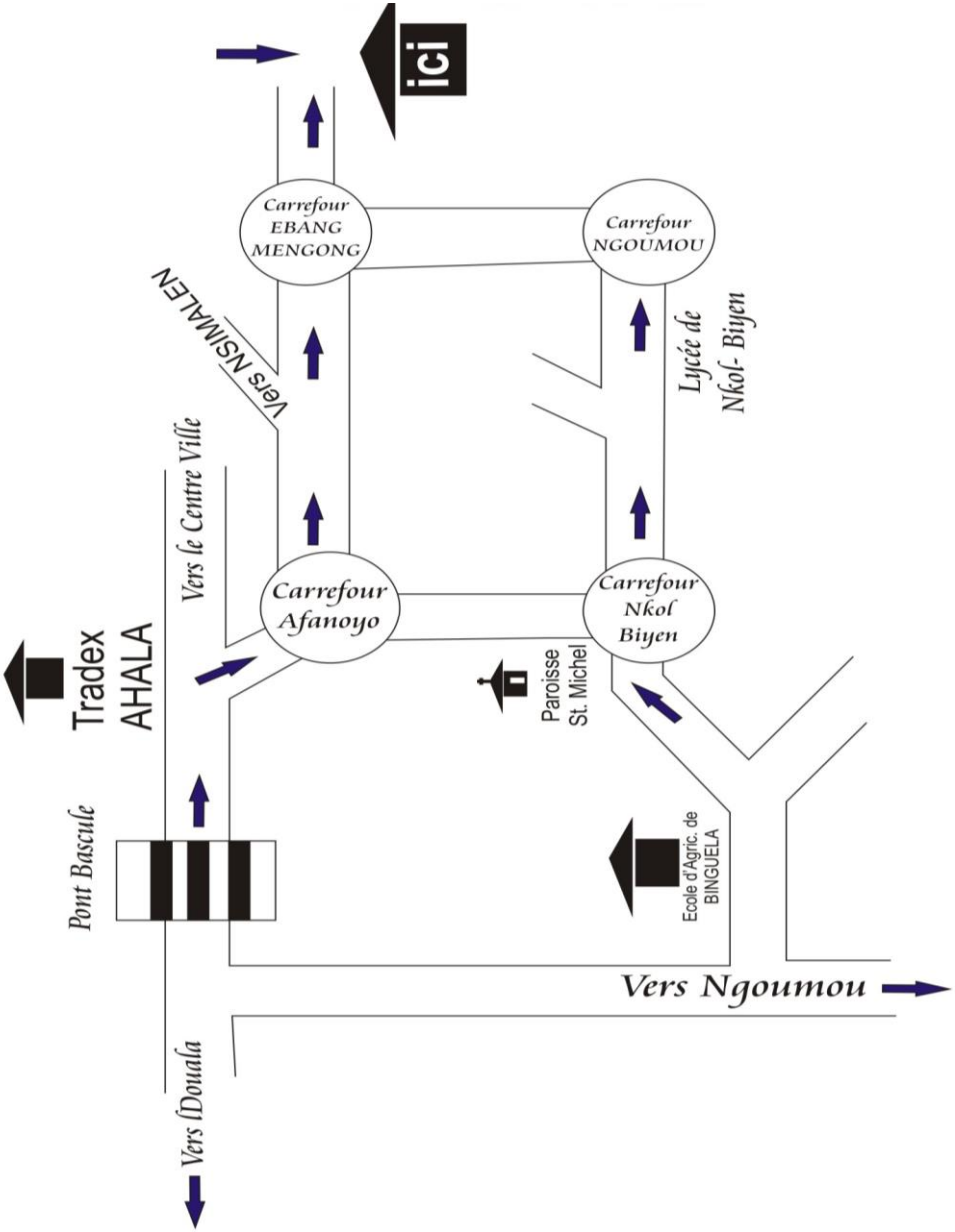
**Vie de l'homme :** Tout être humain est une créature composite et multidimensionnelle, menant simultanément plusieurs vies ou existences parallèles et interdépendantes. L'homme vivant est constitué de quatre composantes :

- la carcasse ou corps charnel, fait d'os, de chair et de sang ;
- l'esprit central (ou âme) ;
- le Saint-Esprit (Esprit de Dieu) ;
- l'esprit de tentation (ou esprit de jouissance des biens terrestres).

Chacune de ces entités a ses exigences, son mode de vie et de fonctionnement propres. C'est l'association harmonieuse de ces quatre composantes qui caractérise l'homme vivant. La durée de vie de l'homme sur Terre dépend de celle de son corps charnel ; elle correspond au temps du passage ou du séjour de l'esprit humain sur Terre, de la naissance à la mort.
Ainsi, le corps humain est, aux yeux de Dieu le Créateur, la composante la plus importante de l'homme, car l'esprit humain a besoin de cette enveloppe pour accomplir sa mission divine sur Terre. Sans cette enveloppe charnelle, l'esprit humain est incapable d'agir efficacement pour faire la volonté de Dieu. C'est également pour cette raison que la planète Terre est appelée *planète des vivants*.

**Vie éternelle :** Jésus-Christ est venu révéler aux hommes qu'il existe une vie après la mort, bien meilleure que celle vécue sur Terre. Il a également enseigné que les hommes ne sont que de passage sur Terre, qu'ils viennent

tous du Paradis (auprès de Dieu le Père, dans le monde des créatures invisibles) et qu'ils y retourneront après la mort. La vie éternelle est le retour de l'homme vers Dieu. L'homme redevient fils de la lumière et redécouvre les merveilles de Dieu : insondables, inimaginables et invisibles à l'œil humain, mais perceptibles par l'esprit. Ces merveilles révèlent toute la splendeur, la beauté, la magnificence, la suprématie et la gloire du Créateur, du Très-Haut, pour les siècles des siècles.




Plan de localisation du ***Centre de Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels*** **« MARIE REINE DE LA MISERICORDE D'ABILI » (CMTHS-MRMA)** au CAMEROUN / BP: 12561 YAOUNDE (CAMEROUN), TEL: (237) 677 31 44 12
Tél: (237) 677 31 44 12 / E-mail : marieconstantin51@yahoo.com

Dans un contexte africain marqué par des souffrances invisibles, des conflits spirituels et des ruptures identitaires profondes, Protocole Thérapeutique de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) propose une approche rigoureuse, humaine et profondément enracinée dans la sagesse africaine et la théologie chrétienne inculturée.

Cet ouvrage présente un cadre clinique structuré pour la prise en charge des handicaps spirituels, intégrant la cure de désenvoûtement, la délivrance progressive, l'anthropologie médicale africaine et l'accompagnement pastoral. Loin de toute dérive mystique ou manipulation de la peur, il affirme une éthique du soin fondée sur le respect de la dignité, de la liberté de conscience et de la responsabilité communautaire.

Conçu comme un outil de discernement, de formation et de transmission, ce livre s'adresse aux thérapeutes, leaders spirituels et communautés engagés dans la restauration intégrale de l'homme africain. Il invite à une médecine de la paix intérieure, de la réconciliation et de la guérison durable.

---

En l'an 2000, **Jean Paul Sylvain SIDA ABENA** a reçu du Seigneur JESUS CHRIST la mission et les pleins pouvoirs de dévoiler au grand jour tous les secrets du Diable, le Malin, afin de sortir les hommes de la prison de l'ignorance qui les maintient dans la persécution du Diable, des démons et du phénomène de la sorcellerie. Jean Paul Sylvain SIDA ABENA est le Fondateur du Centre de traitements spirituels "MARIE REINE DE LA MISERICORDE D'ABILI", dans l'arrondissement de BIKOK (CAMEROUN).

Il est le Précurseur de trois disciplines scientifiques :

1- **L'Etude Systématique de l'Esprit Humain,**
2- **La SORCIORLOGIE** : l'Etude des comportements de déviance, des déviances spirituelles et des évolutions spirituelles du phénomène de la sorcellerie**,**
3- **La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)** dont la Mission est de : **« Guérir l'âme, restaurer le corps, libérer l'esprit ».** Il s'agit d'une médecine inculturée qui associe **Tradition, nature et spiritualité au service de la Santé Holistique. . À ce jour, cette médecine est actuellement codifiée, documentée, enseignée et diffusée par l'Association Mariale d'ABIL (ASMAB).**